



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
RS PRIMA HUSADA MALANG
TRIWULAN II
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Triwulan II Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika). Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilakukan berdasarkan tersedianya data, penggunaan data secara efektif dapat dilakukan secara *evidence-based* praktek klinik dan *evidence-based management*, berhubung sebagian besar rumah sakit mempunyai sumber daya terbatas, maka rumah sakit tidak dapat mengumpulkan data untuk semua hal yang diinginkan. Jadi rumah sakit memilih proses dan hasil *outcome* praktik klinik dan manajemen yang harus dinilai atau diukur dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit memiliki peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dan keselamatan pasien membentuk budaya organisasi rumah sakit dan memberi dampak pada setiap aspek kegiatan berupa Standar Pelayanan Minimal dan pencapaiannya sesuai indikator yang dipergunakan di setiap unit pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada.

Dengan tersusunnya Laporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Triwulan II Tahun 2026 Rumah Sakit Prima Husada Malang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada pada tahun 2025 menetapkan indikator rumah sakit yang sesuai dengan STARKES. Berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikan indikator rumah sakit sebagai berikut: indikator mutu nasioanal (INM), Indikator mutu sasaran keselamatan pasien, Indikator mutu prioritas klinis rumah sakit, Indikator mutu tujuan strategis, indikator mutu perbaikan sistem, Indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit).

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada.

Tujuan Khusus

- a. Mengevaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada melalui pemantauan indikator mutu yang telah ditetapkan pada rapat kerja akhir tahun.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain yang dilakukan oleh tim/ komite/ unit terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas mengenai program mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

BAB II

KEGIATAN PEMANTAUAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT TAHUN 2026

A. Kegiatan Pokok

Kegiatan pemantauan indikator mutu pada Triwulan II Tahun 2026 yang dilaporkan pada Bulan Juli Tahun 2026.

B. Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

C. Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator mutu oleh masing-masing bagian/unit dilakukan setiap bulan, menyusun program perbaikan mutu oleh tim peningkatan mutu rumah sakit dilaporkan pada saat rapat bulanan.
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu
3. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap tiga bulan.
4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu

D. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh petugas pengumpul data unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab pengumpul data. Hasil analisis tersebut kemudian dilaporkan ke kepala instalasi/unit, hasil ditulis pada Form Supervisi dilengkapi laporan tindak lanjut program untuk indikator yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan atau setiap ditemukan suatu permasalahan di setiap instalasi kerja dan ditembuskan Sub Komite Peningkatan Mutu.

BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan capaian indikator mutu nasional RS Prima Husada Malang pada tahun 2026.

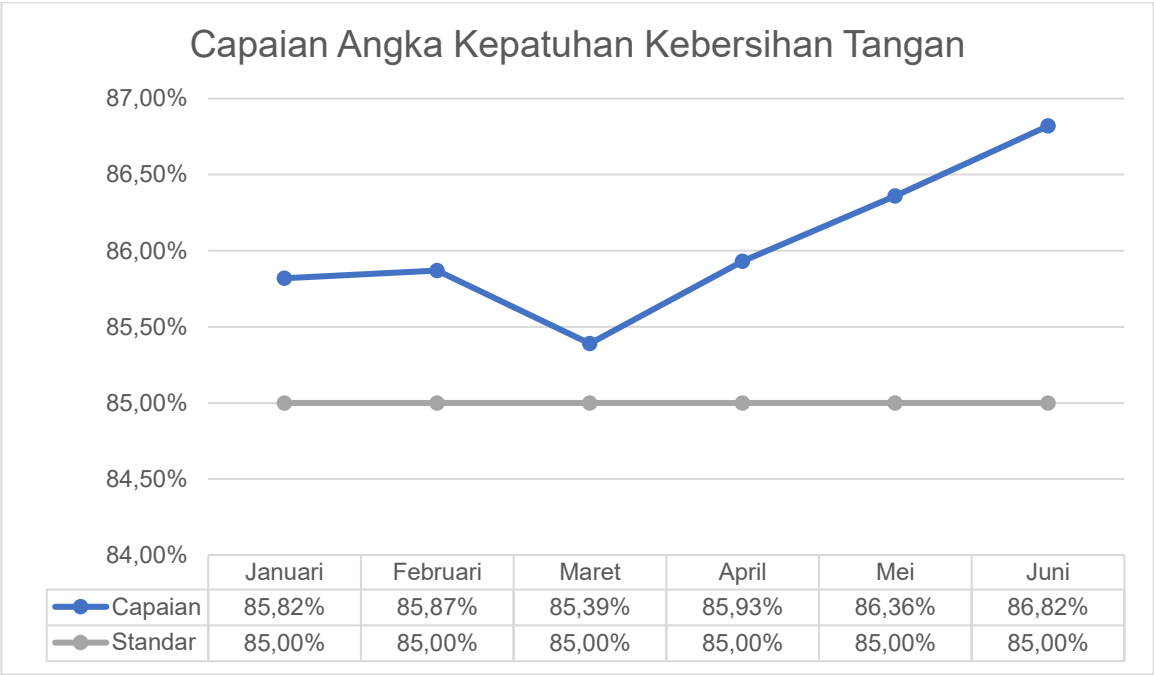
Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Nasional RS Prima Husada Malang Tahun 2026

NO	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW II (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85,82%	85,87%	85,39%	85,93%	86,36%	86,82%	≥ 85%	85,69%	86,37%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,82%	96,88%	96,40%	96,48%	97,13%	97,22%	100%	96,70%	96,94%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99,96%	99,06%	99,89%	99,97%	99,85%	99,93%	100%	99,64%	99,92%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	≥ 80%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89,90%	86,30%	89,20%	95,04%	95,98%	93,80%	≥ 80%	88,47%	94,94%	Dipertahankan
6.	Penundaan Operasi Elektif	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	≤ 5%	0,00%	0,00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66,75%	73,63%	68,35%	87,98%	90,61%	89,86%	≥ 80%	69,58%	89,48%	PDSA
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86,13%	86,07%	86,45%	86,33%	85,81%	86,00%	≥ 80%	86,22%	86,05%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	31,91%	16,11%	18,75%	53,33%	65,22%	87,50%	≥ 80%	22,26%	68,68%	PDSA

11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	91,77%	93.31%	95,60%	96,55%	91,99%	99,06%	100%	93,69%	95,87%	PDSA
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	≥ 80%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%	≥ 76,61	99,79%	99,70%	Dipertahankan

3.1.1 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional

1. Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



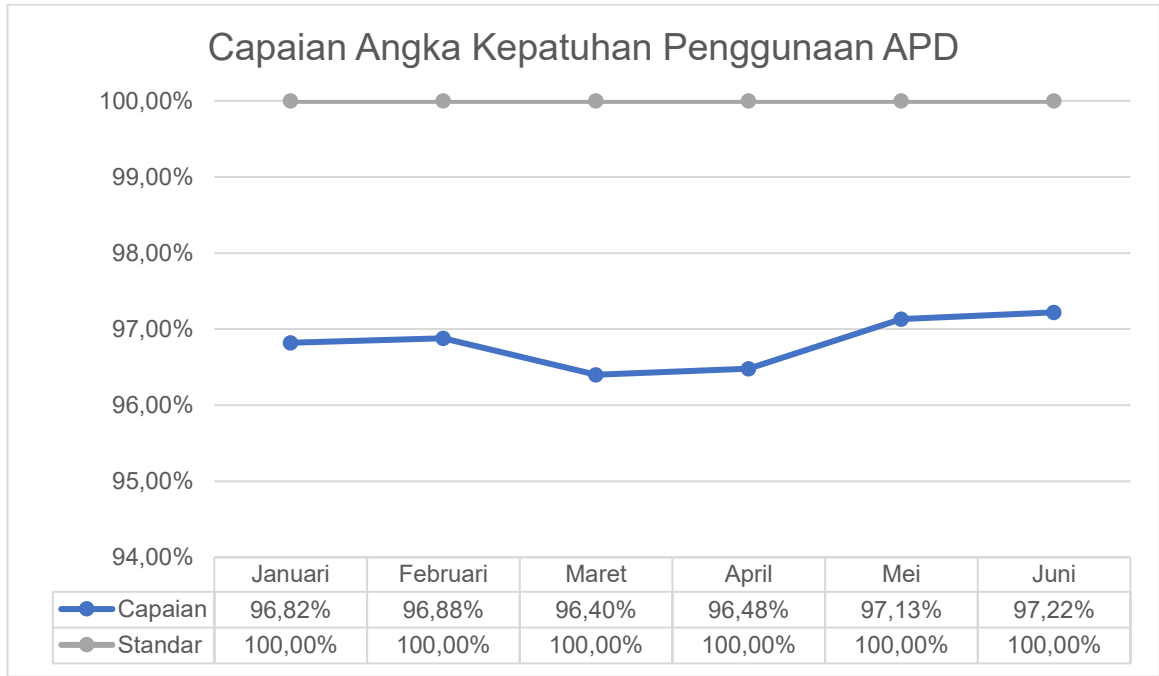
Gambar 3.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan RS Prima Husada Malang

Analisis:

Capaian kepatuhan kebersihan tangan selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang relatif stabil dan konsisten berada di atas standar minimal 85%. Pada bulan Januari capaian sebesar 85,82%, meningkat sedikit menjadi 85,87% pada Februari. Pada bulan Maret terjadi penurunan menjadi 85,39%, namun masih memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya capaian kembali meningkat pada bulan April menjadi 85,93%, bulan Mei menjadi 86,36%, dan bulan Juni mencapai 86,82%. Angka kepatuhan kebersihan tangan tertinggi berasal dari unit IRJA dengan capaian 100%, capaian ini berhasil dipertahankan oleh IRJA selama 2 bulan. Capaian tinggi selanjutnya berasal dari unit ICU dengan capaian 98,04%. Sementara itu, capaian terendah berasal dari unit IRNA 8A dengan capaian 82,41%. Capaian tersebut berada di bawah standar minimal yang ditetapkan ($\geq 85\%$).

Secara keseluruhan terlihat tren peningkatan sebesar 1,00% dari Januari ke Juni. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi, monitoring, dan pengawasan kepatuhan kebersihan tangan yang dilakukan di unit pelayanan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, capaian yang masih berada pada kisaran 85–86% menunjukkan masih terdapat petugas yang belum konsisten melakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 momen hand hygiene, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan mempertahankan capaian yang telah memenuhi standar.

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)



Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) RS Prima Husada Malang

Analisis:

Capaian kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang baik dengan tren yang cenderung meningkat. Pada bulan Januari capaian sebesar 96,82%, meningkat menjadi 96,88% pada Februari. Pada bulan Maret terjadi penurunan menjadi 96,40%, kemudian meningkat kembali menjadi 96,48% pada April, 97,13% pada Mei, dan mencapai 97,22% pada Juni.

Capaian tinggi ini mengindikasikan bahwa sudah banyak unit yang mencapai angka kepatuhan penggunaan APD sebesar 100%, yakni IGD, ICU, IKO, IFRS, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, IRNA 8A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 0,40% dari Januari hingga Juni. Meskipun capaian belum mencapai standar ideal 100%, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar petugas telah menggunakan APD sesuai ketentuan yang berlaku. Penurunan yang terjadi pada bulan Maret dan capaian yang belum optimal mengindikasikan masih terdapat petugas yang belum konsisten menggunakan APD secara lengkap atau sesuai jenis tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD.

Tabel 3.2 PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Juni tahun 2026

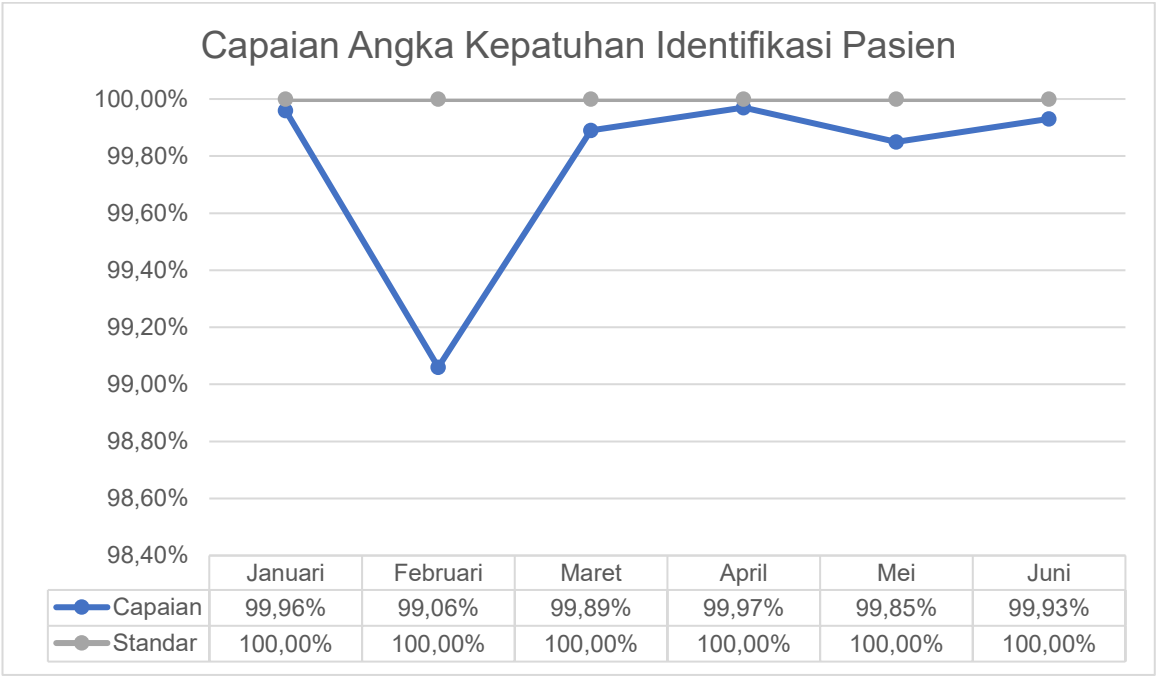
Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD selama Januari–Juni 2026 belum mencapai standar 100%. Meskipun capaian relatif tinggi, masih ditemukan petugas yang belum menggunakan APD secara lengkap dan sesuai dengan risiko pelayanan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko infeksi dan paparan di lingkungan kerja.
Plan	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD melalui penguatan edukasi mengenai penggunaan APD sesuai risiko pelayanan, pemasangan media pengingat di area kerja, supervisi oleh kepala unit, serta pemberian umpan balik terhadap hasil monitoring kepatuhan APD.
Do	Melakukan sosialisasi dan refreshment penggunaan APD, memastikan ketersediaan APD di seluruh unit pelayanan, melaksanakan audit kepatuhan APD secara berkala, serta menyampaikan hasil monitoring kepada masing-masing unit sebagai bahan evaluasi.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penggunaan APD dari 96,48% pada April menjadi 97,13% pada Mei dan 97,22% pada Juni. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi, supervisi, dan monitoring yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan petugas dalam penggunaan APD sesuai ketentuan.
Action	Melanjutkan audit dan supervisi penggunaan APD secara rutin, mempertahankan ketersediaan APD di seluruh unit, memberikan pembinaan pada unit yang masih ditemukan ketidakpatuhan, serta mengupayakan peningkatan capaian menuju standar 100%.

Tabel 3.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Komite PPI, IPCN • Kepala Ruangan	Berkelanjutan

2	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
3	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Gambar 3.3 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

Analisis:

Capaian kepatuhan identifikasi pasien selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten mendekati standar 100%. Pada bulan Januari capaian sebesar 99,96%, kemudian mengalami penurunan menjadi 99,06% pada Februari. Pada bulan Maret capaian kembali meningkat menjadi 99,89%, meningkat lagi menjadi 99,97% pada April, sedikit menurun menjadi 99,85% pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 99,93% pada Juni.

Secara umum capaian indikator menunjukkan stabilitas yang baik dengan rata-rata di atas 99%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kejadian ketidaksesuaian dalam pelaksanaan identifikasi pasien yang menyebabkan capaian belum mencapai 100%. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang apabila tidak dilakukan pengendalian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan seluruh petugas terhadap pelaksanaan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sesuai prosedur yang berlaku.

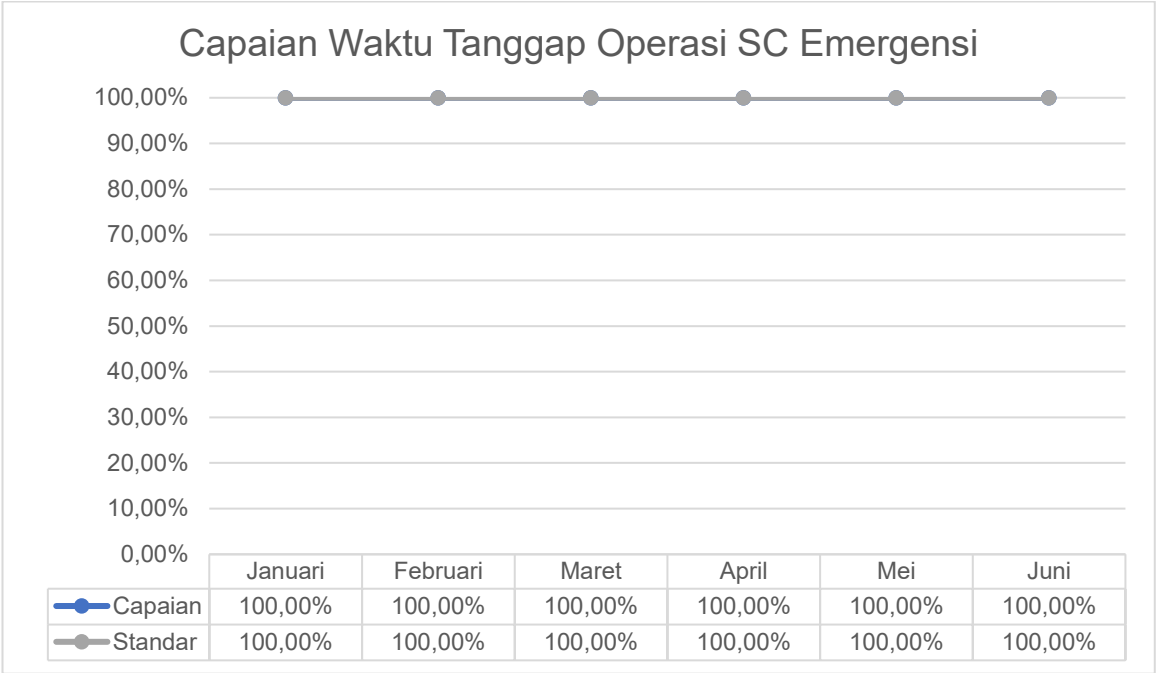
Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Juni tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien periode Januari–Juni 2026 belum mencapai standar 100%, dengan capaian Juni sebesar 99,93%. Masih ditemukan petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang.
Plan	Melaksanakan gerakan "100% Identifikasi Pasien" melalui briefing keselamatan pasien pada setiap pergantian shift, audit observasi rutin oleh kepala unit, pemasangan media pengingat di area pelayanan, serta pemberian umpan balik secara langsung terhadap setiap temuan ketidakpatuhan.
Do	Melaksanakan briefing keselamatan pasien setiap pergantian shift, memasang poster pengingat identifikasi pasien, melakukan audit observasi, dan menyampaikan hasil audit kepada unit terkait.
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian kepatuhan identifikasi pasien meningkat dari 99,85% pada bulan Mei menjadi 99,93% pada bulan Juni 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan audit, edukasi, dan penguatan pengawasan yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien.
Action	Melanjutkan program "100% Identifikasi Pasien", mempertahankan audit dan supervisi rutin, melakukan pembinaan pada unit yang masih ditemukan ketidaksesuaian, serta mengupayakan pencapaian kepatuhan 100% secara konsisten di seluruh unit pelayanan.

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan	Meningkatkan kewaspadaaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	• Kepala ruangan	Berkelanjutan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi



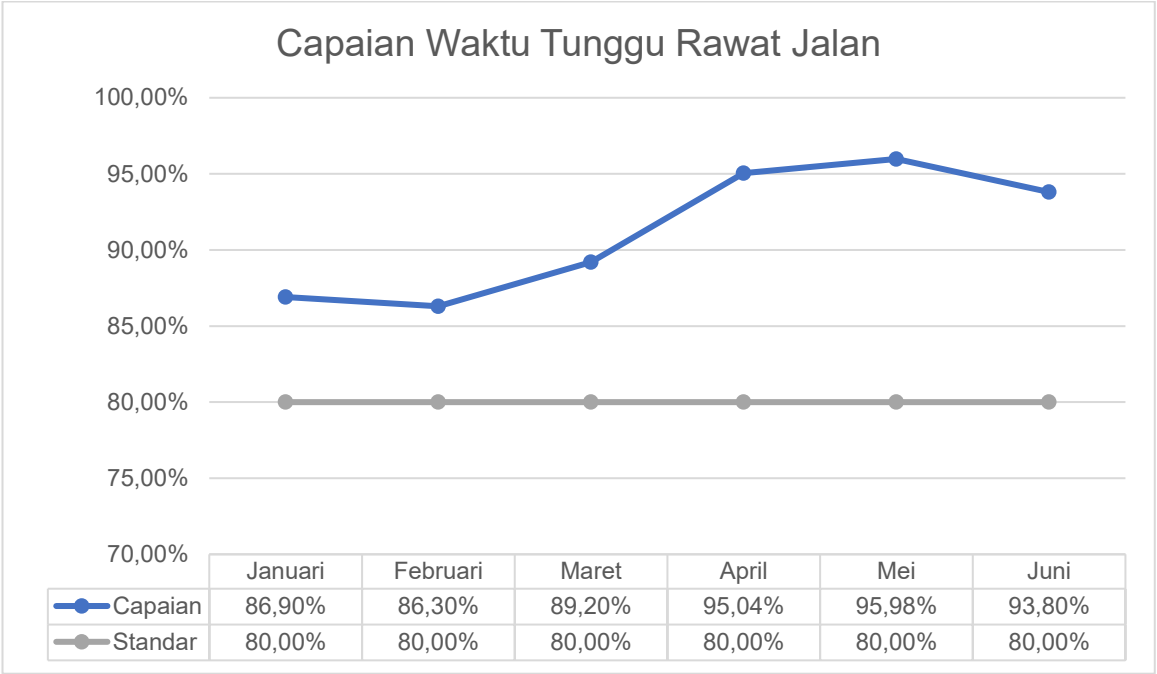
Gambar 3.4 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Analisis:

Capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus seksio sesarea emergensi yang dilakukan telah memenuhi standar waktu tanggap yang ditetapkan rumah sakit, sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan klinis pasien.

Capaian yang konsisten selama enam bulan berturut-turut mencerminkan koordinasi yang baik antara dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, perawat kamar operasi, bidan, serta unit pendukung lainnya. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alur pelayanan emergensi yang efektif turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini. Meskipun capaian telah memenuhi standar, upaya pemantauan dan evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi mutu pelayanan serta mengantisipasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi waktu tanggap di masa mendatang.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan



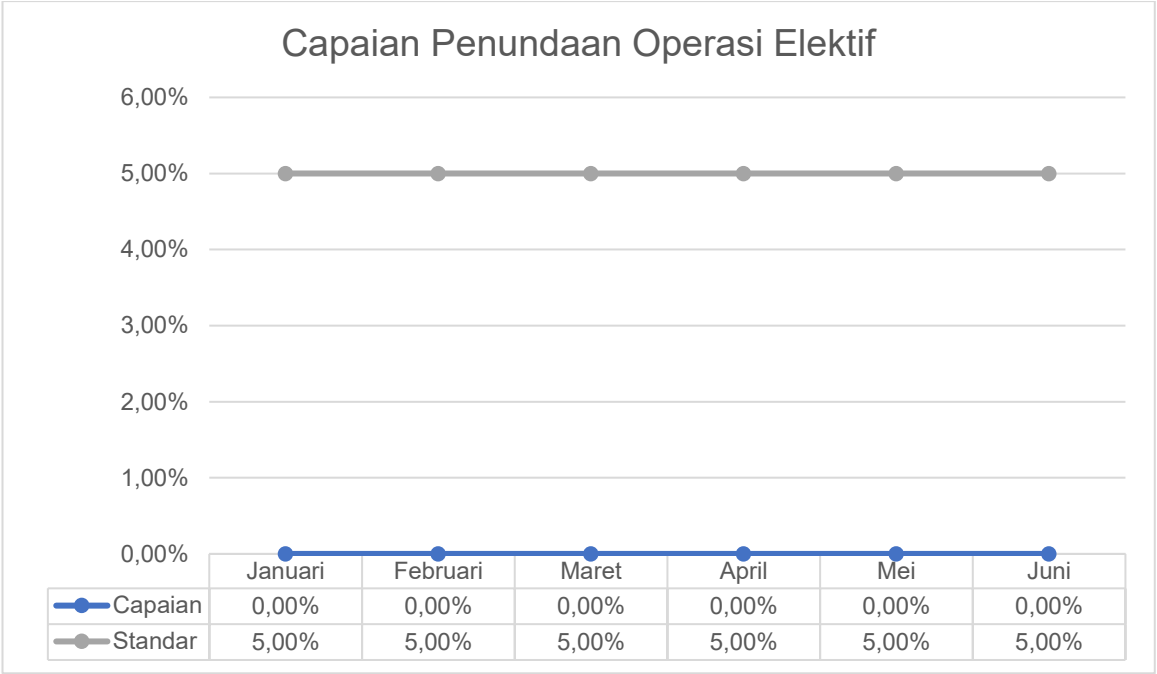
Gambar 3.5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

Analisis:

Capaian indikator waktu tunggu rawat jalan selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang telah memenuhi standar $\geq 80\%$, namun masih mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari capaian sebesar 89,90%, menurun menjadi 86,30% pada Februari, kemudian meningkat menjadi 89,20% pada Maret. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada bulan April menjadi 95,04% dan kembali meningkat menjadi 95,98% pada Mei. Pada bulan Juni capaian sedikit menurun menjadi 93,80%, namun tetap berada di atas standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan tren yang membaik dibandingkan awal tahun. Peningkatan yang terjadi pada April dan Mei mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan alur pelayanan rawat jalan, koordinasi antarunit, serta pengaturan jadwal pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat pasien yang mengalami waktu tunggu melebihi standar sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian dan mencegah terjadinya penumpukan pasien pada jam-jam tertentu.

6. Penundaan Operasi Elektif



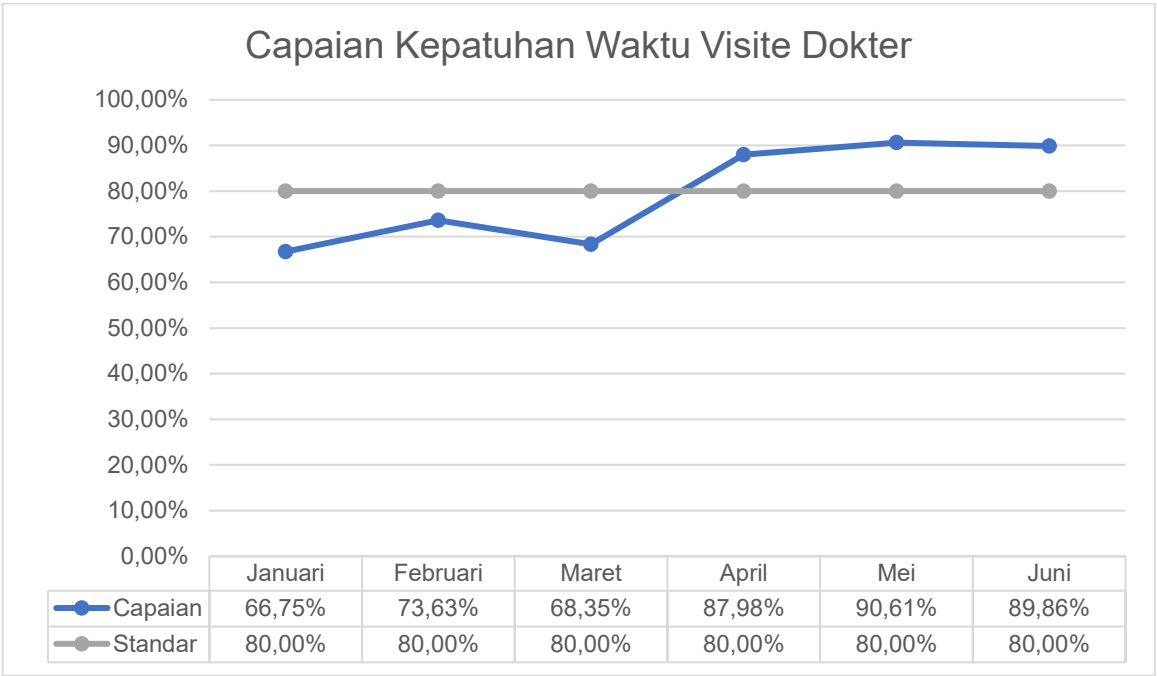
Gambar 3.6 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

Analisis:

Capaian indikator penundaan operasi elektif selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan angka penundaan sebesar 0,00% pada seluruh periode pengukuran. Dari total 160 tindakan operasi elektif yang telah dijadwalkan, tidak terdapat kasus penundaan operasi, sehingga seluruh operasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan operasi, kesiapan pasien, ketersediaan dokter operator, dokter anestesi, ruang operasi, peralatan, bahan medis habis pakai, serta koordinasi antarunit telah berjalan dengan efektif. Tidak adanya penundaan operasi elektif juga mencerminkan pengelolaan pelayanan bedah yang baik sehingga dapat mendukung keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter



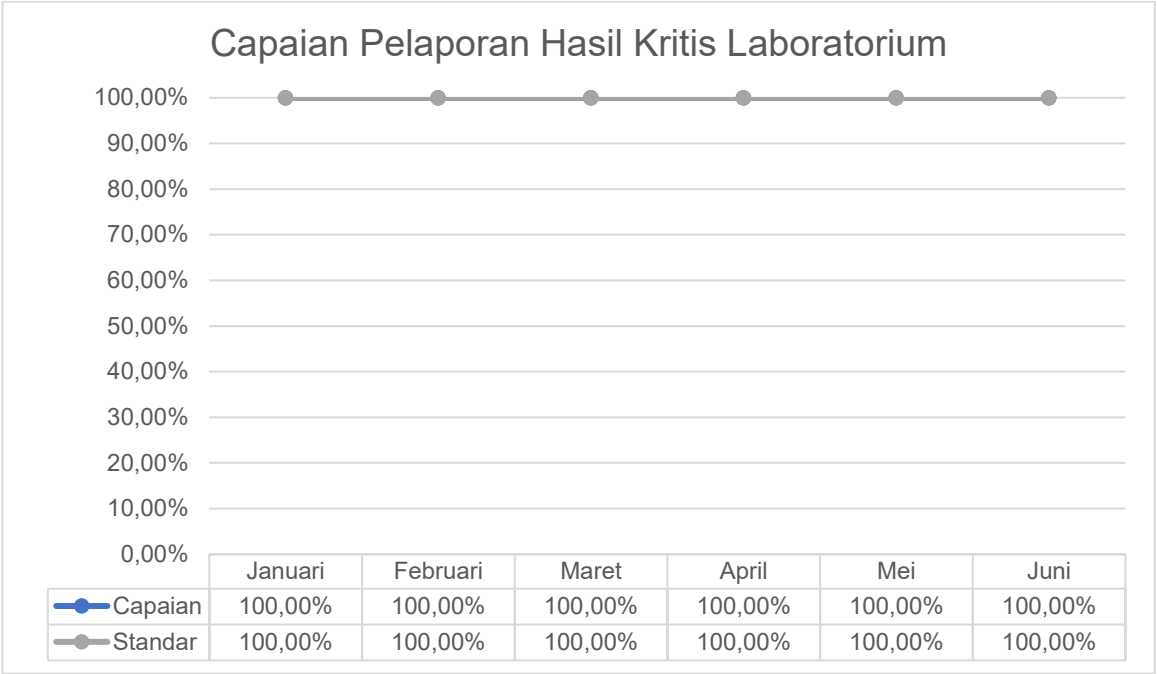
Gambar 3.7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

Analisis:

Capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan meskipun masih belum mencapai standar yang ditetapkan sebesar 100%. Pada bulan Januari capaian sebesar 66,75%, meningkat menjadi 73,63% pada Februari, kemudian menurun menjadi 68,35% pada Maret. Selanjutnya terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan April menjadi 87,98%, meningkat kembali menjadi 90,61% pada Mei, dan sedikit menurun menjadi 89,86% pada Juni.

Secara kumulatif selama periode Januari–Juni 2026, terdapat 1.835 visite dokter yang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dari total 2.042 kesempatan visite yang diamati, sehingga diperoleh capaian sebesar 89,86%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dibandingkan awal tahun, namun masih terdapat 207 visite (10,14%) yang belum dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jadwal praktik dokter yang padat, keterlambatan kedatangan dokter, adanya tindakan atau pelayanan lain yang bersamaan, serta kendala koordinasi pelayanan di unit rawat inap.

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



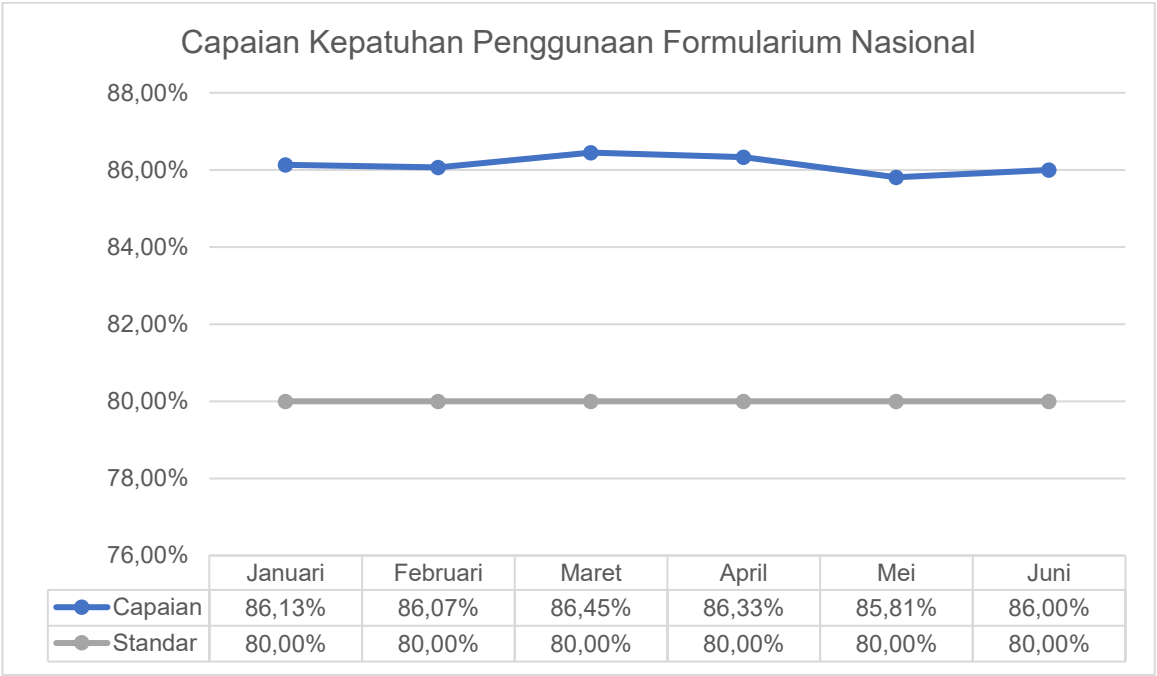
Gambar 3.8 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Analisis:

Capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Dari total 130 hasil kritis laboratorium yang teridentifikasi, seluruhnya (130 hasil kritis) telah dilaporkan kepada dokter atau petugas yang berwenang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian 100%.

Capaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa sistem identifikasi, komunikasi, dan pelaporan hasil kritis laboratorium telah berjalan efektif. Koordinasi yang baik antara petugas laboratorium dengan dokter penanggung jawab pelayanan maupun unit terkait mendukung tersampainya informasi hasil kritis secara cepat dan tepat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung keselamatan pasien dan pengambilan keputusan klinis. Meskipun capaian telah memenuhi standar, pemantauan tetap perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan di kemudian hari.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

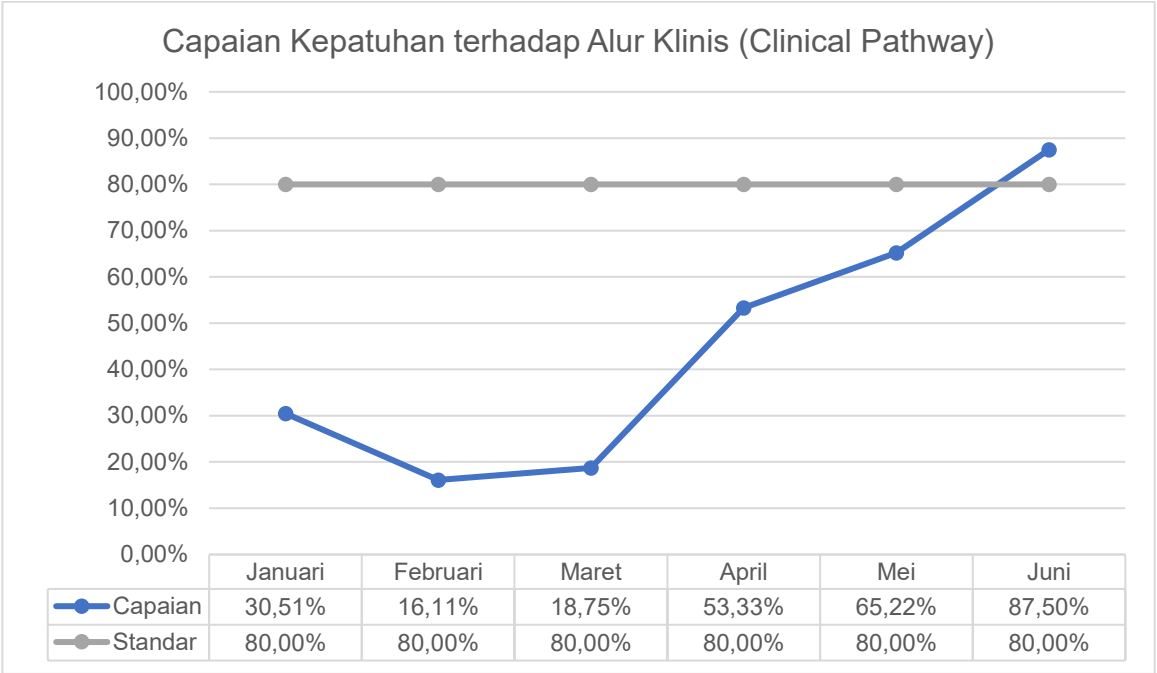


Gambar 3.9 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Analisis:

Capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$. Pada bulan Januari capaian sebesar 86,13%, sedikit menurun menjadi 86,07% pada Februari, kemudian meningkat menjadi 86,45% pada Maret. Pada bulan April capaian menjadi 86,33%, menurun menjadi 85,81% pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 86,00% pada Juni. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dengan rentang nilai antara 85,81% hingga 86,45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peresepan telah mengacu pada Formularium Nasional. Namun demikian, masih terdapat sekitar 14% peresepan yang belum sesuai dengan Fornas. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan terapi tertentu yang belum tercantum dalam Fornas, ketersediaan obat, pertimbangan klinis dokter, maupun kebiasaan peresepan yang belum sepenuhnya mengacu pada Formularium Nasional.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)



Gambar 3.10 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Analisis:

Jumlah pasien dan kepatuhan terhadap CP sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

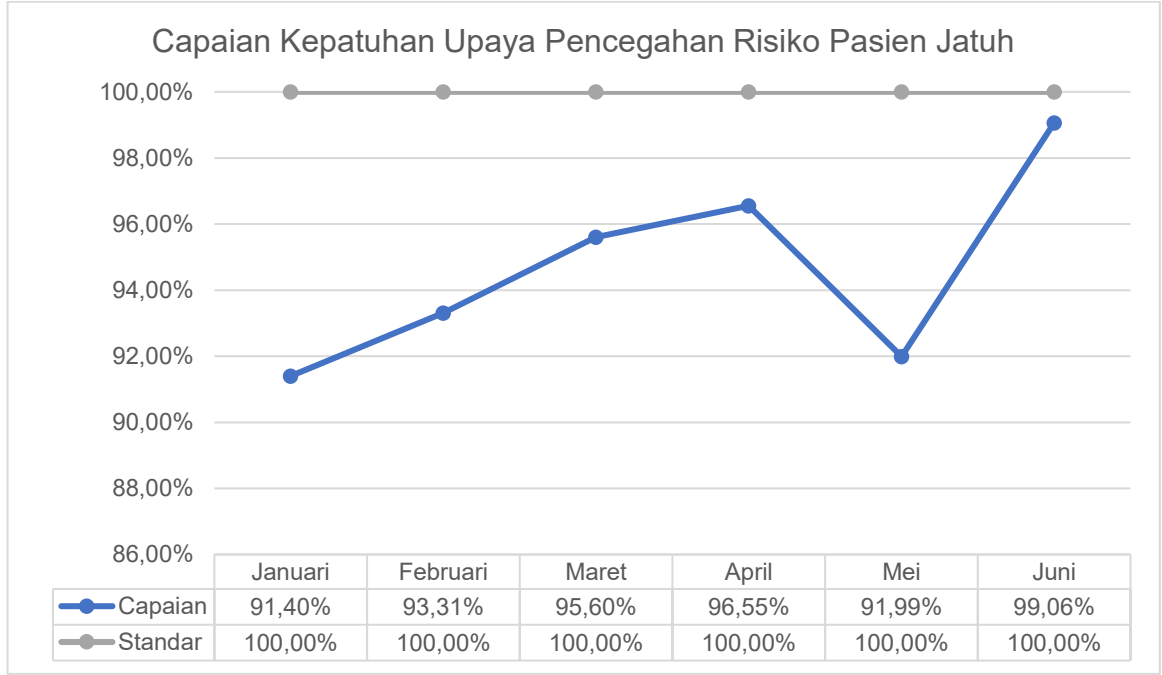
No	Diagnosis	Jumlah Pasien	Kepatuhan CP	
			Patuh	Tidak patuh
1	Hipertensi	0	0	0
2	DM (DM Ulkus)	7	5	2
3	Tuberkulosis	8	8	0
4	HIV	0	0	0
5	Keganasan (Ca Mammae)	1	1	0

Capaian indikator kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada bulan Januari capaian sebesar 31,91%, kemudian menurun menjadi 16,11% pada Februari dan sedikit meningkat menjadi 18,75% pada Maret. Mulai bulan April terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi 53,33%, meningkat kembali menjadi 65,22% pada Mei, dan mencapai 87,50% pada Juni.

Pada bulan Juni, dari 16 rekam medis yang menjadi sampel evaluasi Clinical Pathway, sebanyak 14 rekam medis telah sesuai dengan alur klinis yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 87,50%. Berdasarkan diagnosis yang dievaluasi, terdapat 7 pasien Diabetes Melitus (DM Ulkus) dengan kepatuhan sebanyak 5 kasus (71,43%) dan ketidakpatuhan sebanyak 2 kasus (28,57%). Pada diagnosis Tuberkulosis terdapat 8 pasien dan seluruhnya (100%) telah patuh terhadap Clinical Pathway. Sementara itu, pada diagnosis Keganasan (Ca Mammae) terdapat 1 pasien dan telah memenuhi kepatuhan Clinical Pathway (100%). Tidak terdapat pasien dengan diagnosis Hipertensi maupun HIV yang menjadi sampel evaluasi pada periode ini.

Peningkatan capaian yang terjadi menunjukkan bahwa upaya sosialisasi, pendampingan pengisian Clinical Pathway, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pelaksanaan alur klinis. Namun demikian, masih terdapat 2 kasus pada kelompok DM Ulkus yang belum memenuhi ketentuan Clinical Pathway sehingga perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, baik terkait pelaksanaan pelayanan maupun kelengkapan dokumentasi.

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh



Gambar 3.11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Analisis:

Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada bulan Januari capaian sebesar 91,77%, meningkat menjadi 93,31% pada Februari dan 95,60% pada Maret. Peningkatan masih berlanjut pada April dengan capaian 96,55%, kemudian mengalami penurunan menjadi 91,99% pada Mei. Pada bulan Juni terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 99,06%.

Pada bulan Juni, dari 3.600 kesempatan observasi yang dilakukan, sebanyak 3.566 tindakan pencegahan risiko jatuh telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,06%. Dibandingkan capaian bulan Januari, terjadi peningkatan sebesar 7,29%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan risiko pasien jatuh di unit pelayanan telah berjalan semakin baik dan mendekati standar yang ditetapkan.

Meskipun capaian telah sangat baik, masih terdapat 34 observasi (0,94%) yang belum memenuhi seluruh komponen upaya pencegahan risiko jatuh. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh petugas konsisten melaksanakan asesmen risiko jatuh, pemasangan penanda risiko jatuh, edukasi pasien dan keluarga, serta intervensi pencegahan lainnya sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 3.8 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

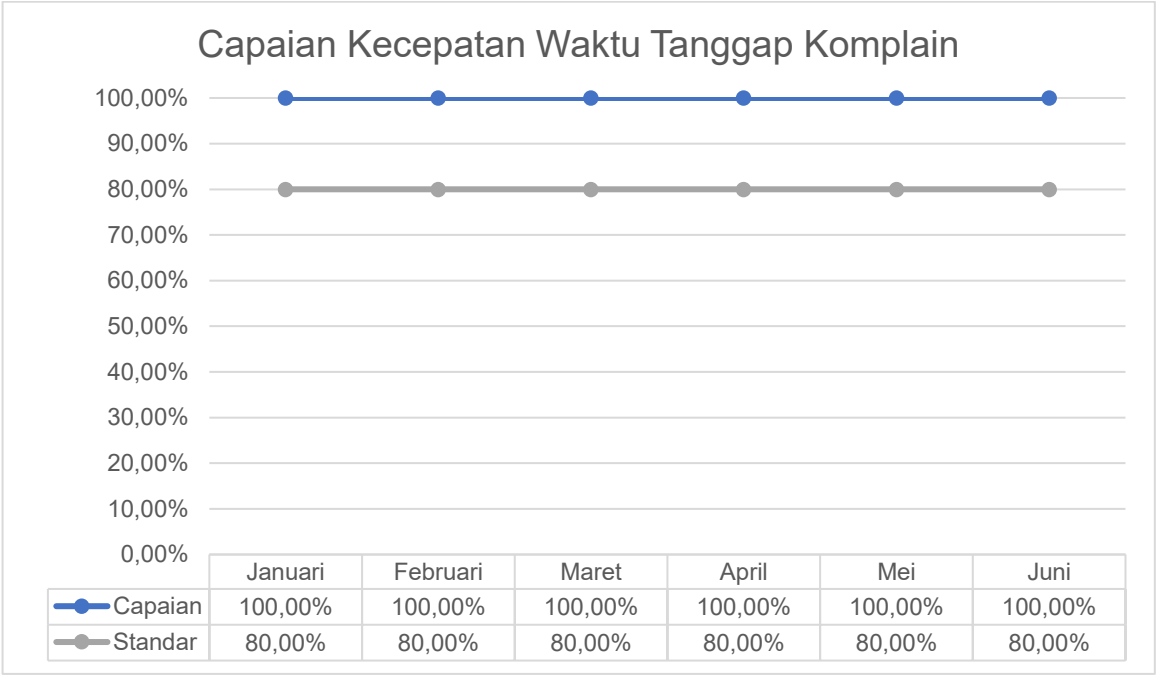
Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh belum mencapai standar 100%. Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan asesmen risiko jatuh, pemasangan penanda risiko jatuh, edukasi pasien dan keluarga, serta implementasi intervensi pencegahan sesuai prosedur.
Plan	Melaksanakan program "Zero Fall Risk" melalui penguatan asesmen risiko jatuh pada pasien, supervisi harian oleh kepala ruang, pemasangan media pengingat pencegahan risiko jatuh di unit perawatan.
Do	Melakukan sosialisasi ulang SPO pencegahan risiko jatuh, audit kepatuhan secara berkala, supervisi pelaksanaan asesmen dan intervensi risiko jatuh, serta edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai langkah-langkah pencegahan risiko jatuh
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh meningkat dari 91,99% pada bulan Mei menjadi 99,06% pada bulan Juni 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penguatan supervisi, edukasi, dan monitoring yang dilakukan telah meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh sesuai standar.
Action	Mempertahankan pelaksanaan audit dan supervisi rutin, melakukan monitoring rutin pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) serta menjadikan kepatuhan pencegahan risiko jatuh sebagai salah satu fokus monitoring keselamatan pasien untuk mencapai dan mempertahankan capaian 100%.

Tabel 3.9 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan	Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien	• Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap • Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster • Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

				• Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis		
2	Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh • Melakukan audit kepatuhan secara berkala • Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian • Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

12. Kecepatan waktu tanggap komplain



Gambar 3.12 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

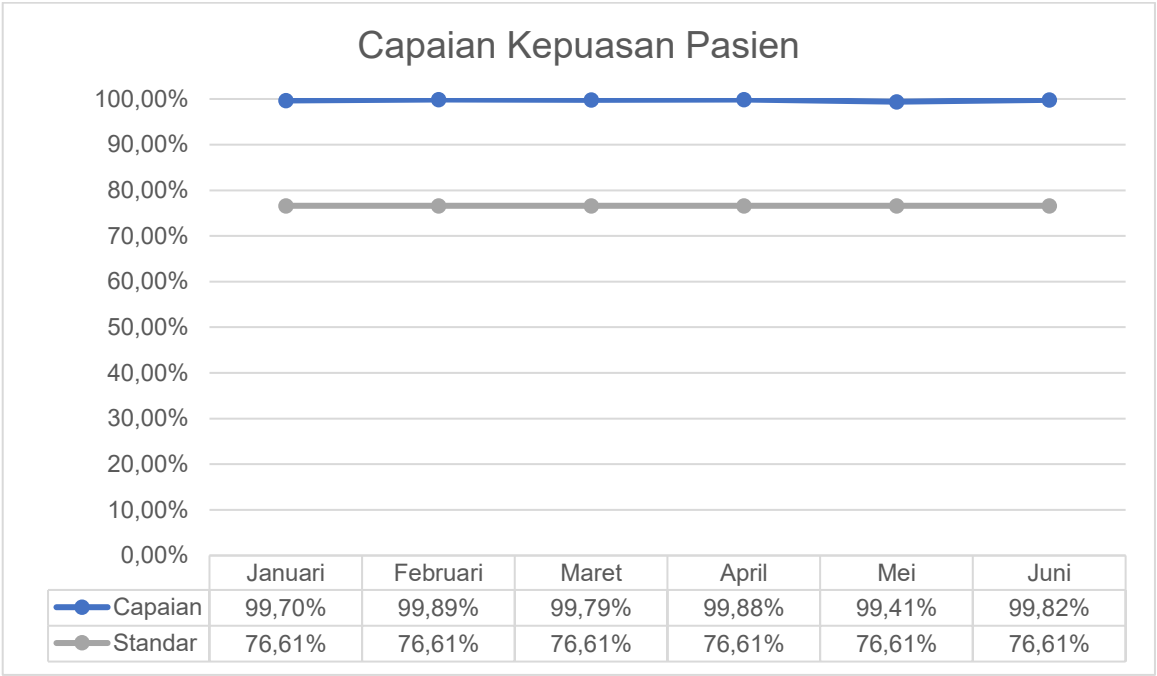
Analisis:

Capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Pada periode Juni 2026 terdapat 4 komplain yang diterima rumah sakit dan seluruhnya (4 komplain) telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu tanggap yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Capaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan, pelaporan, koordinasi, dan penyelesaian komplain telah berjalan efektif. Respons yang cepat terhadap komplain merupakan salah satu bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh masukan dalam upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Meskipun capaian telah memenuhi standar, evaluasi terhadap substansi komplain tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area pelayanan yang masih memerlukan perbaikan sehingga tidak hanya berfokus pada kecepatan respons, tetapi juga pada efektivitas penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh pasien atau keluarga.

13. Kepuasan Pasien



Gambar 3.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien

Analisis:

Capaian indikator kepuasan pasien selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan. Pada bulan Januari capaian sebesar 99,70%, meningkat menjadi 99,89% pada Februari, kemudian sedikit menurun menjadi 99,79% pada Maret. Pada bulan April capaian kembali meningkat menjadi 99,88%, menurun menjadi 99,41% pada Mei, dan meningkat kembali menjadi 99,82% pada Juni. Pada bulan Juni 2026, dari 1.104 responden yang mengisi survei kepuasan pasien, sebanyak 1.102 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,82%. Hanya terdapat 2 responden (0,18%) yang menyatakan belum puas. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik. Meskipun capaian indikator sangat tinggi dan stabil, evaluasi terhadap aspek pelayanan yang masih menjadi sumber ketidakpuasan tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Masukan dari pasien dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, komunikasi petugas, maupun aspek fasilitas yang masih memerlukan penyempurnaan.

3.2 Pemantauan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

1. Pemantauan Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

Tabel 3.10 Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW I (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	92,42%	92,14%	92,90%	92,83%	93,06%	93,00%	100%	92,49%	92,96%	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100%	100,00%	95,51%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85,05%	85,70%	85,91%	86,59%	83,10%	84,15%	100%	85,55%	84,61%	PDSA
6.	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	84,61%	87,11%	92,08%	98,42%	90,16%	99,11%	100%	87,93%	95,90%	PDSA

3.2.1 Analisis Capaian Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

1) Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pada pasien rawat jalan mencapai 100% setiap bulan. Seluruh capaian telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu 100%, menunjukkan bahwa petugas secara konsisten melakukan proses verifikasi identitas pasien sebelum menyerahkan obat.

Pencapaian yang stabil selama enam bulan berturut-turut mencerminkan bahwa implementasi prosedur identifikasi pasien telah berjalan dengan baik dan menjadi budaya kerja di unit pelayanan rawat jalan. Kepatuhan ini juga menunjukkan efektivitas sosialisasi, supervisi, serta pemahaman petugas terhadap pentingnya identifikasi pasien sebagai salah satu sasaran keselamatan pasien.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% berkontribusi dalam mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat akibat salah pasien, sehingga risiko insiden keselamatan pasien dapat diminimalkan. Meskipun target telah tercapai secara konsisten, upaya monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara

berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga serta mengantisipasi potensi penurunan capaian di masa mendatang.

2) Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)

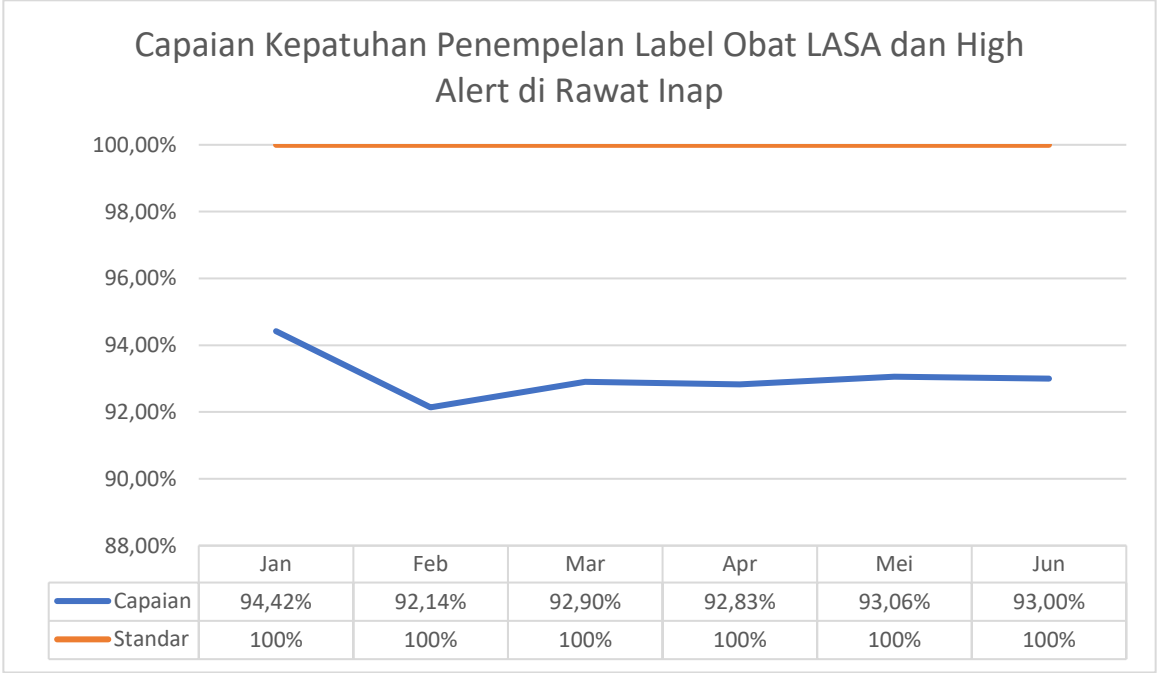


Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi mencapai 100% pada seluruh bulan pengamatan. Capaian tersebut telah memenuhi standar rumah sakit yang ditetapkan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan radiologi yang termasuk kategori kritis telah dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian selama enam bulan berturut-turut menunjukkan bahwa proses komunikasi hasil kritis radiologi telah berjalan secara efektif, didukung oleh kepatuhan petugas terhadap SPO, koordinasi yang baik antarprofesi, serta mekanisme pelaporan yang telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh petugas terkait.

Pencapaian ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien karena memastikan hasil kritis yang memerlukan tindak lanjut segera dapat diterima oleh dokter secara tepat waktu, sehingga keputusan klinis dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Meskipun capaian telah memenuhi target secara konsisten, kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi tetap perlu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan mutu pelayanan serta mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan hasil kritis di masa mendatang.

3) Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap



Analisis:
Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan penempelan label obat LASA (Look Alike Sound Alike) dan obat High Alert di rawat inap berturut-turut sebesar 92,42%, 92,14%, 92,90%, 92,83%, 93,06%, dan 93,00%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar 100% yang telah ditetapkan rumah sakit.

Secara tren, capaian menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Pada bulan Februari terjadi penurunan sebesar 0,28% dibanding Januari, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Maret menjadi 92,90%. Pada bulan April capaian sedikit menurun menjadi 92,83%, selanjutnya meningkat pada bulan Mei menjadi 93,06% yang merupakan capaian tertinggi selama semester pertama, dan sedikit menurun pada bulan Juni menjadi 93,00%.

Belum tercapainya standar dapat disebabkan oleh masih ditemukannya obat LASA dan High Alert yang belum ditemplei label sesuai ketentuan, baik akibat kelalaian petugas, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengecekan, maupun adanya penambahan stok obat yang belum segera dilakukan pelabelan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pengambilan dan pemberian obat yang dapat berdampak pada keselamatan pasien.

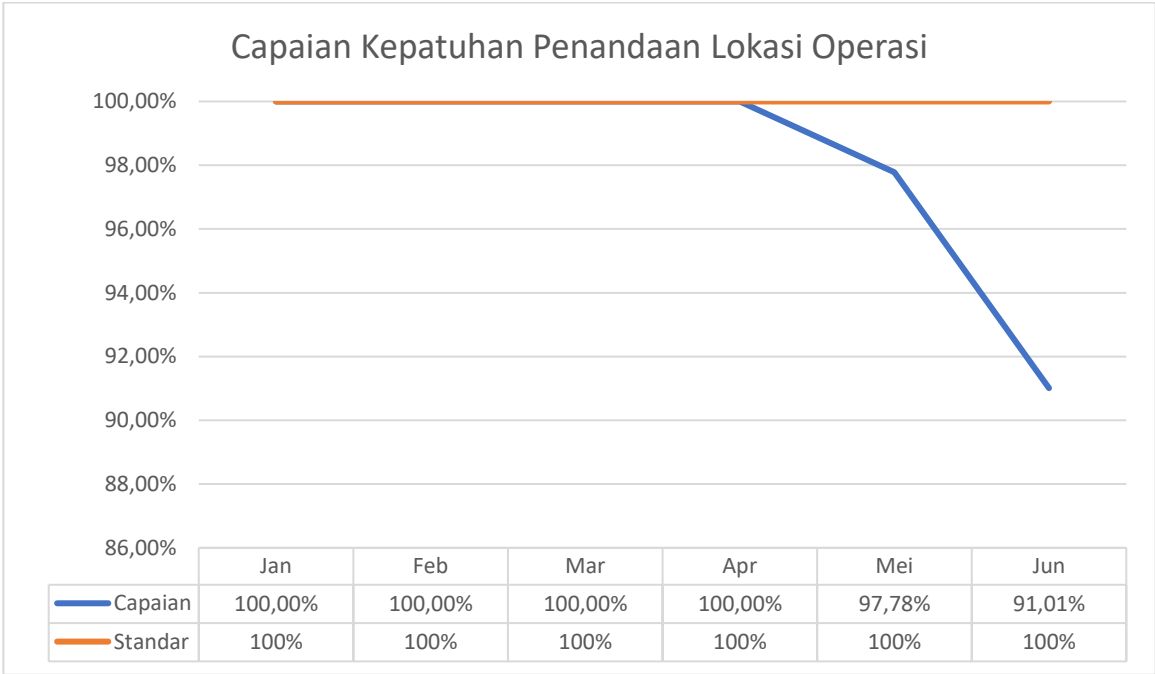
Meskipun capaian menunjukkan kecenderungan membaik dibanding awal tahun, diperlukan upaya perbaikan yang lebih intensif melalui penguatan supervisi, pelaksanaan inspeksi rutin terhadap penyimpanan obat, peningkatan koordinasi antara instalasi farmasi dan unit perawatan, serta pemberian umpan balik kepada petugas terkait hasil monitoring. Dengan upaya tersebut diharapkan kepatuhan penempelan label obat LASA dan High Alert dapat terus meningkat dan mendekati standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 PDSA Capaian Indikator Kepatuhan Penempelan Label obat LASA dan obat High Alert di rawat inap bulan Juni Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat High Alert di rawat inap selama Januari–Juni 2026 berturut-turut sebesar 92,42%, 92,14%, 92,90%, 92,83%, 93,06%, dan 93,00%. Capaian masih berada di bawah standar rumah sakit sebesar 100%, yang menunjukkan masih ditemukannya obat LASA dan High Alert yang belum diberi label sesuai ketentuan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pengambilan dan pemberian obat.
Plan	Memperkuat pengawasan terhadap pelabelan obat LASA dan High Alert melalui inspeksi rutin bersama Instalasi Farmasi dan unit rawat inap, melakukan sosialisasi ulang terkait daftar obat LASA dan High Alert, menetapkan pengecekan pelabelan sebagai bagian dari supervisi kepala ruangan, serta memberikan umpan balik berkala kepada unit yang belum mencapai kepatuhan 100%.
Do	Dilakukan sosialisasi kepada petugas mengenai pentingnya pelabelan obat LASA dan High Alert, monitoring berkala di seluruh unit rawat inap, pengecekan ketersediaan label pada obat yang baru diterima, serta penyampaian hasil monitoring kepada kepala ruangan dan petugas farmasi untuk segera dilakukan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan capaian dibanding awal tahun, dari 92,42% pada Januari menjadi 93,00% pada Juni. Capaian tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 93,06%. Meskipun terjadi perbaikan, standar 100% belum tercapai sehingga masih diperlukan penguatan implementasi dan pengawasan pelabelan obat di seluruh unit rawat inap.
Action	Melanjutkan monitoring dan audit kepatuhan secara rutin, meningkatkan keterlibatan kepala ruangan dalam pengawasan pelabelan obat, memastikan seluruh obat LASA dan High Alert yang masuk langsung diberi label sebelum didistribusikan ke unit pelayanan, serta menjadikan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dalam rapat mutu unit dan rumah sakit untuk mencapai target kepatuhan 100%.

4) Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)



Analisis:
Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan penandaan lokasi operasi berturut-turut sebesar 100%, 100%, 100%, 100%, 97,78%, dan

91,01%. Pada periode Januari–April, capaian telah memenuhi standar rumah sakit sebesar 100%. Namun, pada bulan Mei terjadi penurunan menjadi 97,78% dan kembali menurun pada bulan Juni menjadi 91,01%, sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

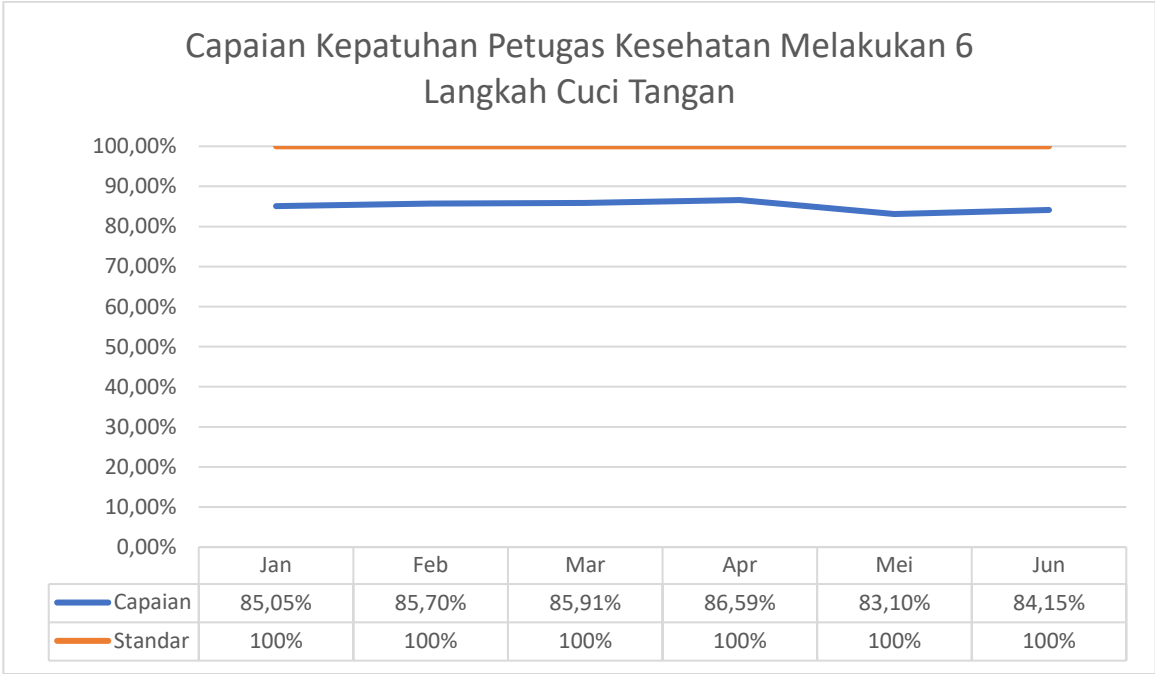
Penurunan capaian menunjukkan masih terdapat pasien yang belum mendapatkan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan pelaksanaan SPO dan verifikasi praoperasi. Apabila tidak ditindaklanjuti, hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko kejadian salah lokasi operasi.

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketidakpatuhan yang terjadi, penguatan pelaksanaan Surgical Safety Checklist, serta peningkatan supervisi dan koordinasi dengan dokter operator dan tim bedah agar kepatuhan kembali mencapai standar 100%.

Tabel 3.12 PDSA Capaian Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi bulan Juni Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan penandaan lokasi operasi pada Januari–April mencapai 100%, namun menurun pada Mei menjadi 97,78% dan Juni menjadi 91,01%, sehingga tidak memenuhi standar rumah sakit sebesar 100%. Masih ditemukan pasien yang belum mendapatkan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur sebelum tindakan dilakukan.
Plan	Memperkuat kepatuhan pelaksanaan penandaan lokasi operasi melalui sosialisasi ulang SPO kepada dokter operator dan tim bedah, optimalisasi penggunaan Surgical Safety Checklist, serta meningkatkan supervisi dan verifikasi penandaan sebelum pasien masuk kamar operasi.
Do	Dilakukan pengingat kepada dokter operator dan perawat kamar operasi terkait kewajiban penandaan lokasi operasi, monitoring kepatuhan melalui audit rekam medis dan observasi pelaksanaan time out, serta penyampaian hasil monitoring kepada unit terkait.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya penurunan capaian dari 100% pada Januari–April menjadi 97,78% pada Mei dan 91,01% pada Juni. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi penandaan lokasi operasi belum dilakukan secara konsisten pada seluruh kasus operasi.
Action	Melakukan evaluasi terhadap setiap ketidakpatuhan yang ditemukan, memperkuat pengawasan oleh kepala kamar operasi dan Komite PMKP, serta menjadikan verifikasi penandaan lokasi operasi sebagai poin wajib yang harus dipastikan sebelum tindakan operasi dimulai guna mencapai kembali standar 100%.

5) Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan berturut-turut sebesar 85,05%, 85,70%, 85,91%, 86,59%, 83,10%, dan 84,15%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.

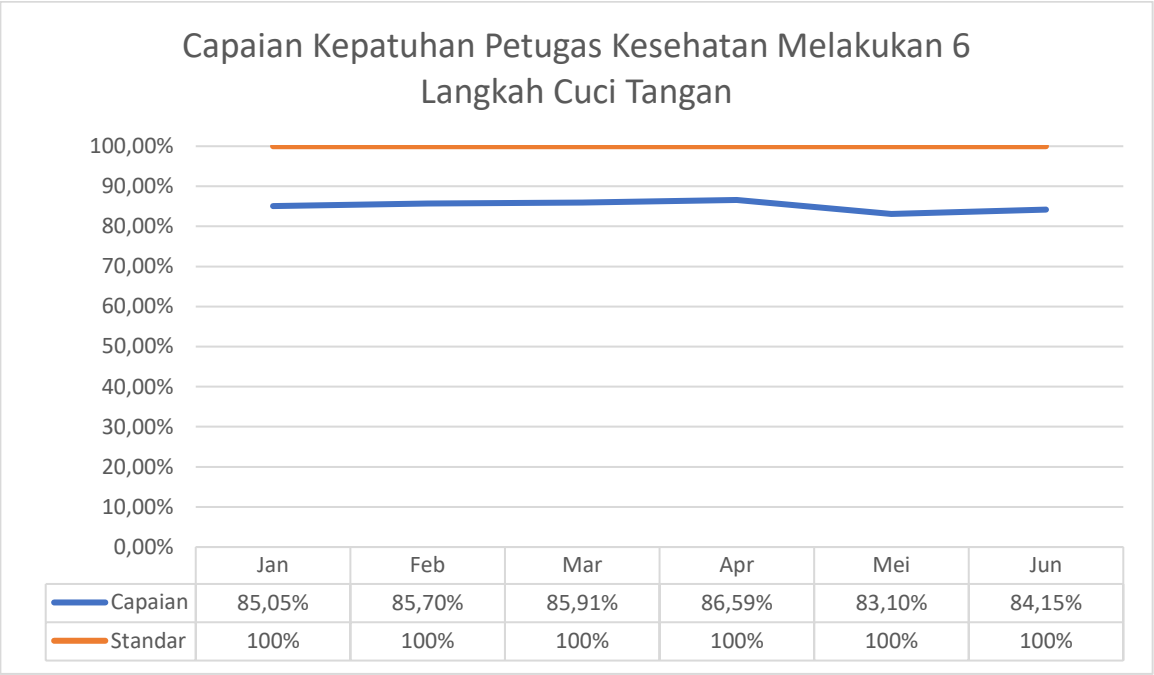
Capaian menunjukkan tren meningkat dari Januari hingga April, kemudian menurun pada Mei dan sedikit meningkat kembali pada Juni. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan 6 langkah cuci tangan masih belum konsisten dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan edukasi, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 Langkah Cuci Tangan bulan Juni Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan periode Januari–Juni sebesar 85,05%, 85,70%, 85,91%, 86,59%, 83,10%, dan 84,15%, masih belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan petugas dalam melakukan kebersihan tangan sesuai prosedur.
Plan	Meningkatkan kepatuhan melalui penguatan edukasi 6 langkah cuci tangan, peningkatan monitoring kepatuhan di unit pelayanan, pemberian umpan balik hasil evaluasi, serta penguatan peran kepala unit dalam melakukan supervisi.
Do	Melakukan sosialisasi dan pengingat kembali mengenai 6 langkah cuci tangan, melaksanakan audit kepatuhan secara berkala, serta menyampaikan hasil monitoring kepada unit terkait sebagai bahan perbaikan.
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian meningkat hingga April dengan capaian tertinggi 86,59%, namun mengalami penurunan pada Mei dan Juni. Hal ini menunjukkan upaya edukasi dan monitoring perlu dilakukan secara konsisten agar kepatuhan dapat meningkat.
Action	Melanjutkan monitoring rutin, melakukan evaluasi pada unit dengan capaian rendah, memperkuat supervisi kepala unit, serta mempertahankan program edukasi kebersihan tangan untuk meningkatkan kepatuhan menuju standar 100%.

6) Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan berturut-turut sebesar 85,05%, 85,70%, 85,91%, 86,59%, 83,10%, dan 84,15%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%. Capaian menunjukkan tren meningkat dari Januari hingga April, kemudian menurun pada Mei dan sedikit meningkat kembali pada Juni. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan 6 langkah cuci tangan masih belum konsisten dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan. Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan edukasi, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Tabel 3.14 PDSA Capaian Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 Langkah Cuci Tangan

Problem	Capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan periode Januari–Juni sebesar 85,05%, 85,70%, 85,91%, 86,59%,
---------	--

	83,10%, dan 84,15%, masih belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan petugas dalam melakukan kebersihan tangan sesuai prosedur.
Plan	Meningkatkan kepatuhan melalui penguatan edukasi 6 langkah cuci tangan, peningkatan monitoring kepatuhan di unit pelayanan, pemberian umpan balik hasil evaluasi, serta penguatan peran kepala unit dalam melakukan supervisi.
Do	Melakukan sosialisasi dan pengingat kembali mengenai 6 langkah cuci tangan, melaksanakan audit kepatuhan secara berkala, serta menyampaikan hasil monitoring kepada unit terkait sebagai bahan perbaikan.
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian meningkat hingga April dengan capaian tertinggi 86,59%, namun mengalami penurunan pada Mei dan Juni. Hal ini menunjukkan upaya edukasi dan monitoring perlu dilakukan secara konsisten agar kepatuhan dapat meningkat.
Action	Melanjutkan monitoring rutin, melakukan evaluasi pada unit dengan capaian rendah, memperkuat supervisi kepala unit, serta mempertahankan program edukasi kebersihan tangan untuk meningkatkan kepatuhan menuju standar 100%.

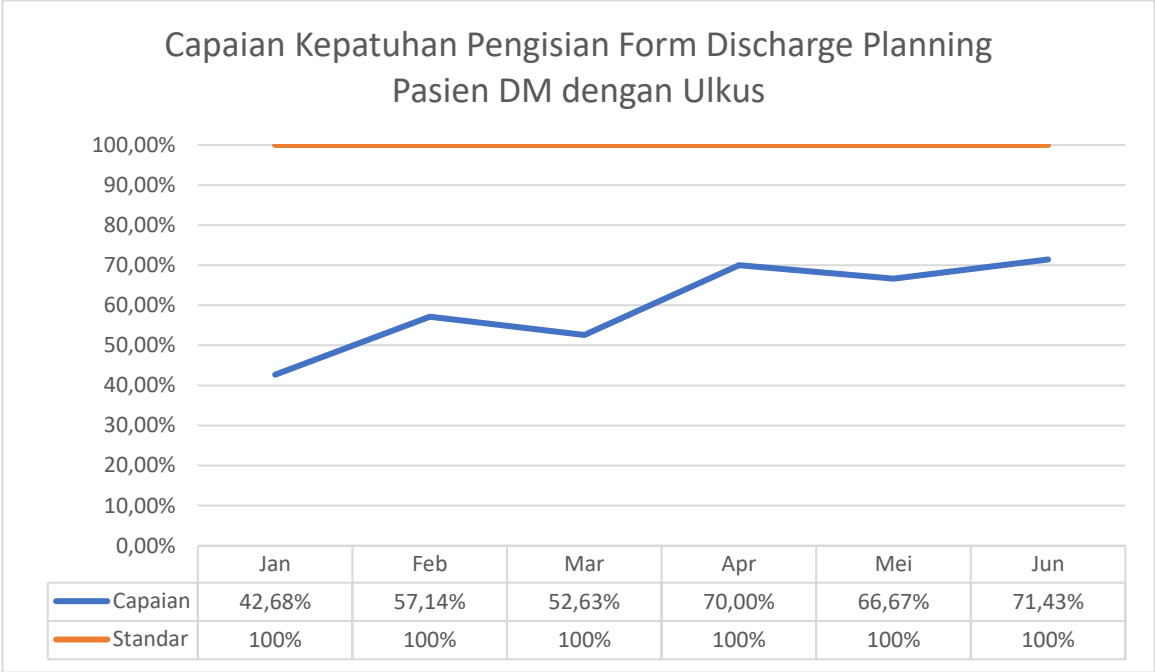
2. Pemantauan Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW I (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	42,68%	57,14%	52,63%	70,00%	66,67%	71,43%	100%	50,82%	69,37%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	57,14%	42,86%	73,68%	60,00%	83,33%	71,43%	100%	57,89%	71,59%	PDSA

3.2.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

1) Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)



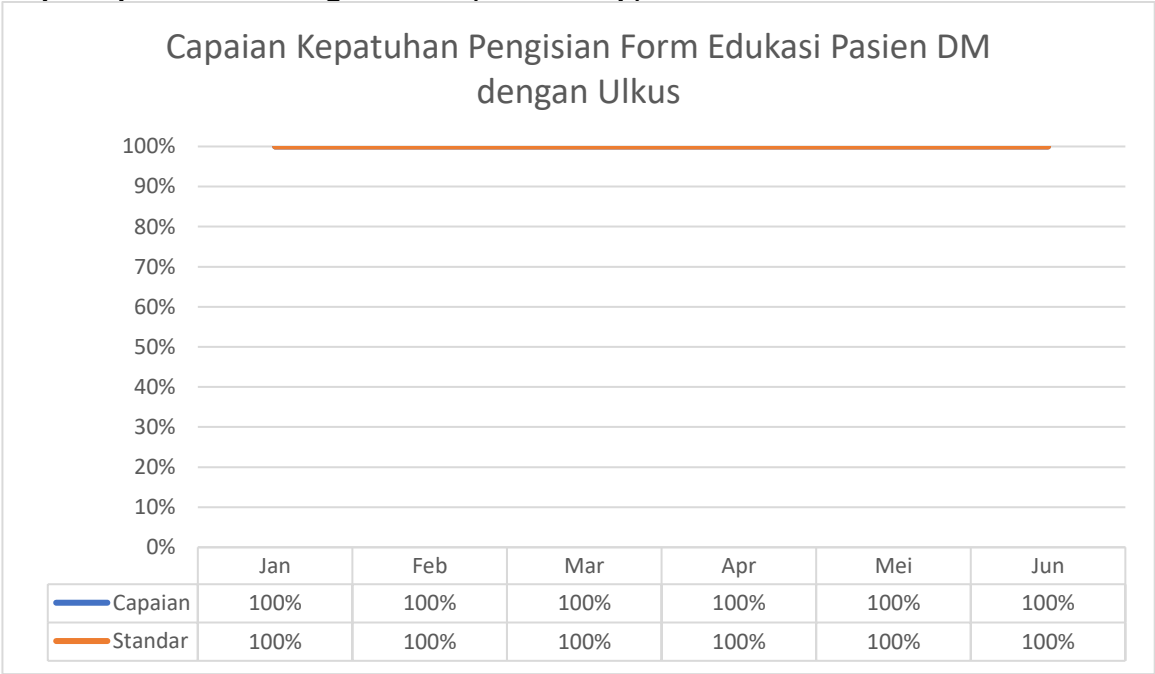
Analisis:
Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan pengisian form *discharge planning* pasien DM dengan ulkus sebesar **42,68%, 57,14%, 52,63%, 70,00%, 66,67%, dan 71,43%**. Selama periode tersebut, capaian indikator **belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%**. Secara tren, capaian menunjukkan peningkatan dibanding awal tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi pada bulan Maret dan Mei. Capaian tertinggi diperoleh pada bulan Juni sebesar **71,43%**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan dan dokumentasi *discharge planning*. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan monitoring, supervisi, dan kepatuhan petugas dalam pengisian form agar seluruh pasien DM dengan ulkus mendapatkan *discharge planning* yang terdokumentasi lengkap sesuai standar.

Tabel 3.16 PDSA Capaian Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning Pasien DM dengan Ulkus bulan Juni Tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan pengisian form <i>discharge planning</i> pasien DM dengan ulkus Januari–Juni sebesar 42,68%, 57,14%, 52,63%, 70,00%, 66,67%, dan 71,43%, masih belum mencapai standar 100%. Pengisian form belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasien yang memenuhi kriteria.
Plan	Meningkatkan kepatuhan pengisian form <i>discharge planning</i> melalui sosialisasi ulang kepada dokter dan perawat, penguatan monitoring kelengkapan dokumen, serta menetapkan verifikasi form sebagai bagian dari proses pemulangan pasien.

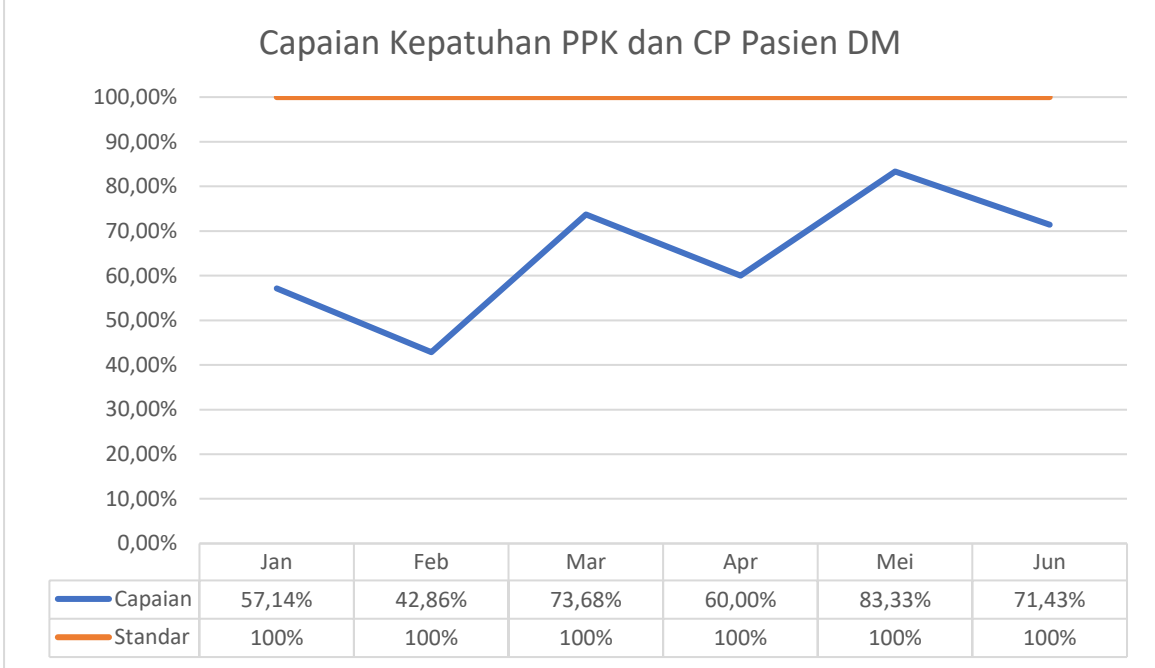
Do	Melakukan edukasi kepada petugas terkait pentingnya <i>discharge planning</i> , monitoring kelengkapan form pada rekam medis pasien DM dengan ulkus, dan memberikan umpan balik kepada unit rawat inap terkait hasil evaluasi.
Study	Hasil monitoring menunjukkan tren peningkatan dari 42,68% pada Januari menjadi 71,43% pada Juni. Meskipun terdapat perbaikan, capaian masih belum memenuhi standar sehingga diperlukan upaya yang lebih konsisten.
Action	Melanjutkan audit dan monitoring rutin, memperkuat supervisi kepala ruangan, serta memastikan form <i>discharge planning</i> menjadi dokumen wajib yang diverifikasi sebelum pasien dipulangkan agar kepatuhan dapat terus meningkat menuju target 100%.

2) Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)



Analisis:
Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus mencapai **100%** pada seluruh bulan pengamatan. Capaian tersebut telah memenuhi standar rumah sakit sebesar **100%** secara konsisten selama enam bulan berturut-turut. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian dan dokumentasi edukasi kepada pasien DM dengan ulkus telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian juga mencerminkan komitmen tenaga kesehatan dalam mendukung kesinambungan perawatan pasien melalui edukasi yang terdokumentasi dengan lengkap.

3) Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)



Analisis:
Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan PPK dan CP pasien DM rawat inap sebesar **57,14%, 42,86%, 73,68%, 60,00%, 83,33%, dan 71,43%**. Selama periode tersebut, capaian indikator **belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%**. Capaian menunjukkan fluktuasi setiap bulan dengan nilai terendah pada Februari sebesar **42,86%** dan tertinggi pada Mei sebesar **83,33%**. Meskipun terdapat peningkatan dibanding awal tahun, implementasi dan dokumentasi PPK serta CP masih belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasien DM rawat inap. Diperlukan penguatan monitoring, evaluasi kepatuhan pengisian CP, serta peningkatan koordinasi antarprofesi agar pelaksanaan pelayanan sesuai PPK dan CP dapat berjalan lebih optimal dan mencapai standar yang ditetapkan.

Tabel 3.17 PDSA Capaian Kepatuhan PPK dan CP DM

Problem	Capaian kepatuhan PPK dan CP pasien DM rawat inap Januari–Juni sebesar 57,14%, 42,86%, 73,68%, 60,00%, 83,33%, dan 71,43%, masih belum mencapai standar 100%. Implementasi dan dokumentasi CP belum dilakukan secara konsisten.
Plan	Meningkatkan kepatuhan melalui sosialisasi ulang PPK dan CP, penguatan koordinasi dokter dan perawat, serta monitoring rutin terhadap

	kelengkapan dan kesesuaian pengisian CP.
Do	Melakukan audit rekam medis pasien DM, memberikan umpan balik kepada DPJP dan unit terkait, serta mendampingi pelaksanaan evaluasi CP secara berkala.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya perbaikan capaian dibanding awal tahun, namun masih terjadi fluktuasi dan belum mencapai target 100%.
Action	Melanjutkan audit dan evaluasi rutin, memperkuat supervisi pelaksanaan CP, serta menjadikan hasil monitoring sebagai bahan tindak lanjut perbaikan di unit pelayanan.

3. Tujuan Strategis

Tabel 3.18 Capaian Indikator Mutu Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW I (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26				
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3	11	7	4	0	3	7	PDSA



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, jumlah kejadian komplain pasien/keluarga melalui Google Review berturut-turut sebanyak 5, 1, 3, 11, 7, dan 4 kejadian. Selama periode tersebut, capaian indikator belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 0 kejadian.

Jumlah komplain mengalami fluktuasi, dengan kejadian tertinggi pada bulan April sebanyak 11 komplain dan terendah pada bulan Februari sebanyak 1 komplain. Komplain yang muncul menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara harapan pasien/keluarga dengan pelayanan yang diterima, sehingga diperlukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan tindak lanjut perbaikan.

Upaya peningkatan perlu dilakukan melalui analisis setiap komplain, percepatan respons terhadap keluhan, peningkatan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga, serta penguatan budaya pelayanan prima agar kejadian komplain dapat diminimalkan.

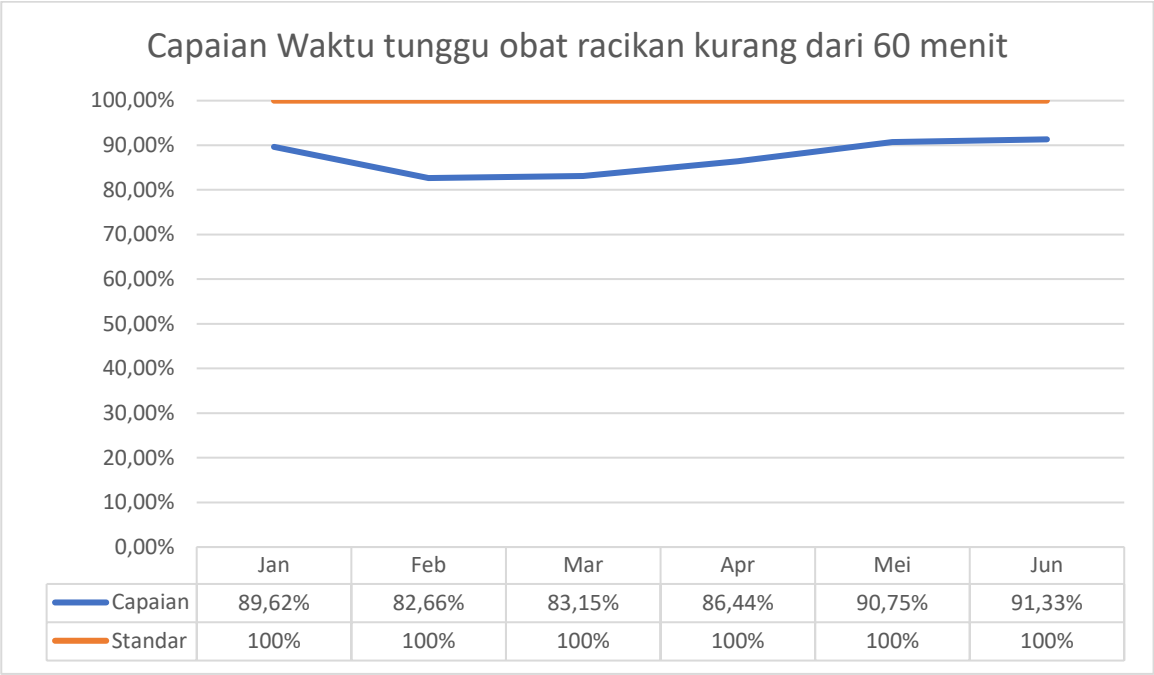
Tabel 3.19 PDSA Capaian Indikator Kejadian Komplain Pasien/Keluarga Melalui *Google Review*:

Problem	Terdapat komplain pasien/keluarga melalui Google Review selama Januari–Juni sebanyak 5, 1, 3, 11, 7, dan 4 kejadian, sehingga belum mencapai standar rumah sakit yaitu 0 kejadian.
Plan	Melakukan analisis penyebab setiap komplain, meningkatkan respons terhadap keluhan pasien, memperkuat komunikasi efektif petugas dengan pasien/keluarga, serta melakukan edukasi pelayanan prima kepada petugas.
Do	Melakukan tindak lanjut terhadap setiap komplain yang masuk, memberikan klarifikasi dan penyelesaian kepada pasien/keluarga, serta menyampaikan hasil evaluasi komplain kepada unit terkait sebagai bahan perbaikan.
Study	Hasil monitoring menunjukkan jumlah komplain masih berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada bulan April. Hal ini menunjukkan masih diperlukan penguatan upaya pencegahan komplain melalui peningkatan kualitas pelayanan dan komunikasi.
Action	Melanjutkan monitoring komplain secara berkala, melakukan evaluasi tren dan akar masalah komplain, serta meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan untuk mencegah kejadian berulang dan meningkatkan kepuasan pasien.

4. Perbaikan Sistem

Tabel 3.20 Capaian Indikator Mutu Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW I (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26				
1.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	89,62%	82,66%	83,15%	86,44%	90,75%	91,33%	100%	85,14%	89,51%	PDSA



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit berturut-turut sebesar 89,62%, 82,66%, 83,15%, 86,44%, 90,75%, dan 91,33%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.

Capaian mengalami penurunan pada bulan Februari, kemudian menunjukkan tren peningkatan secara bertahap hingga bulan Juni dengan capaian tertinggi sebesar 91,33%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelayanan obat racikan, namun masih terdapat sebagian pelayanan yang melebihi standar waktu yang ditetapkan.

Keterlambatan dapat dipengaruhi oleh proses penyiapan obat racikan yang membutuhkan waktu lebih lama, jumlah resep yang meningkat pada jam tertentu, serta proses verifikasi sebelum obat diserahkan kepada pasien. Diperlukan evaluasi alur pelayanan, optimalisasi koordinasi antara unit pelayanan dan farmasi, serta monitoring rutin agar waktu tunggu obat racikan dapat mencapai target 100%.

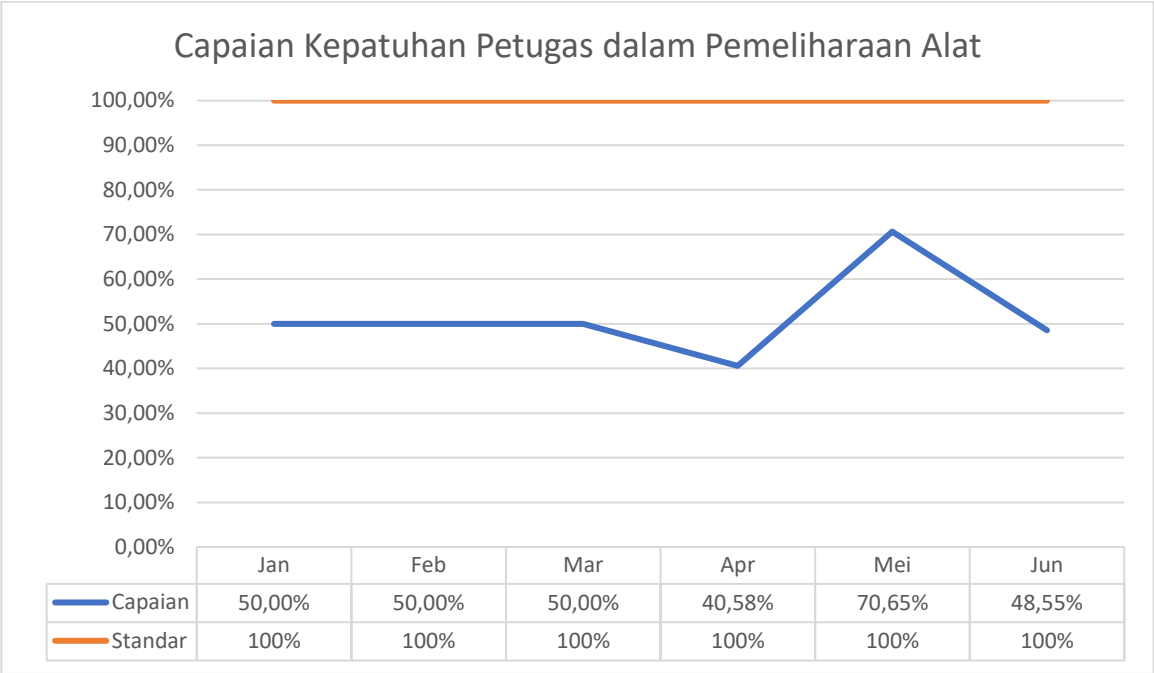
Tabel 3.21 PDSA Capaian Indikator Waktu Tunggu Obat Racikan Kurang Dari 60 Menit

Problem	Capaian waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit Januari–Juni sebesar 89,62%, 82,66%, 83,15%, 86,44%, 90,75%, dan 91,33%, masih belum mencapai standar 100%. Masih terdapat pelayanan obat racikan yang melebihi waktu tunggu yang ditetapkan.
Plan	Melakukan evaluasi alur pelayanan obat racikan, mengidentifikasi penyebab keterlambatan, meningkatkan koordinasi antara unit pelayanan dengan Instalasi Farmasi, serta melakukan monitoring waktu tunggu secara berkala.
Do	Melakukan pemantauan waktu pelayanan resep racikan, memberikan umpan balik kepada petugas farmasi terkait hasil monitoring, serta melakukan perbaikan alur kerja untuk mempercepat proses penyiapan obat.
Study	Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan capaian dari 82,66% pada Februari menjadi 91,33% pada Juni. Namun, capaian masih belum memenuhi target sehingga diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan.
Action	Melanjutkan evaluasi rutin terhadap waktu tunggu obat racikan, mengoptimalkan pembagian tugas petugas farmasi, serta melakukan tindak lanjut terhadap faktor penyebab keterlambatan agar capaian dapat mencapai standar 100%.

5. Manajemen Risiko

Tabel 3.22 PDSA Indikator Kepatuhan Petugas dalam Pemeliharaan Alat

No	Judul Indikator	Bulan						Standar	Rata-Rata TW I (Jan-Feb)	Rata-Rata TW II (Apr-Jun)	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26				
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	50%	50%	50%	40,58%	70,65%	48,55%	100%	50,00%	53,26%	PDSA



Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat sebesar 50%, 50%, 50%, 40,58%, 70,65%, dan 48,55%, sehingga belum mencapai standar 100%.

Capaian menunjukkan pemeliharaan alat belum dilakukan secara konsisten sesuai jadwal. Meskipun terjadi peningkatan pada bulan Mei, capaian kembali menurun pada Juni. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan monitoring, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan alat untuk mencegah risiko kerusakan alat yang dapat mengganggu pelayanan.

Tabel 3.23 PDSA Indikator Kepatuhan Petugas dalam Pemeliharaan Alat

Problem	Capaian kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat Januari–Juni sebesar 50%, 50%, 50%, 40,58%, 70,65%, dan 48,55%, masih jauh di bawah standar 100%. Hal ini menunjukkan pemeliharaan alat belum dilakukan secara konsisten sesuai jadwal.
---------	---

Plan	Meningkatkan kepatuhan pemeliharaan alat melalui penyusunan jadwal pemeliharaan yang jelas, penguatan sosialisasi kepada petugas, peningkatan monitoring oleh penanggung jawab unit, serta evaluasi kelengkapan dokumentasi pemeliharaan.
Do	Melakukan pengingat kepada petugas terkait kewajiban pemeliharaan alat, monitoring pelaksanaan pemeliharaan sesuai jadwal, serta memberikan umpan balik kepada unit yang belum melaksanakan pemeliharaan.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan pada bulan Mei menjadi 70,65%, namun mengalami penurunan kembali pada Juni menjadi 48,55%. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan belum berjalan konsisten dan masih membutuhkan penguatan pengawasan.
Action	Melakukan evaluasi rutin terhadap kepatuhan pemeliharaan alat, meningkatkan supervisi kepala unit, memastikan dokumentasi pemeliharaan lengkap, serta melakukan tindak lanjut terhadap unit yang belum memenuhi target untuk mencapai standar 100%.

BAB IV
HASIL KEGIATAN MUTU PRIORITAS UNIT

4.1 Pemantauan Indikator Mutu Unit

4.1.1 Instalasi Gawat Darurat

Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gawat Darurat Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,05%	86,05%	82,67%	83,35%	83,55%	84,86%							84,42%	Belum mencapai standar (Mar-Jun)
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	96,99%	100%	97,16%	100%							99,03%	Belum mencapai standar (Maret, Mei)
4	Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,16%	100%							99,53%	Belum mencapai standar (Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,05%	86,05%	86,05%	88,24%	87,95%	87,50%							86,97%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan perhitungan	100%	96,59%	96,65%	77,86%	100%							94,22%	Belum mencapai standar (Maret-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm pengkajian awal IGD dan SPRI	0%	Blm dilakukan perhitungan	54,72%	1,41%	0,86%	1,27%	4,82%							12,62%	Belum mencapai standar
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan	0 kejadian	Blm dilakukan perhitungan	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

	pasien dengan EWS															
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	0 kejadian	Blm dilakukan perhitungan	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

4.1.2 IRNA 2A

Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2A Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,86%	86,11%	86,21%	86,42%	86,28%	86,28%							86,19%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	98,78%	100%	100%	99,32%							99,68%	Sudah mencapai standar

5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	63,13%	78,21%	77,44%	72,38%	70,11%	100%							76,88%	Belum mencapai standar (Jan-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	85,71%	85,96%	85,45%	85,19%	84,62%	84,62%							85,26%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	15,29%	8,43%	5,63%	11,11%	7,07%	100%							24,59%	Belum mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	15,06%	8,82%	5,63%	11,11%	9,24%	100%							24,98%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%							12,50%	Sudah mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	0%	2,44%	3,81%	48,91%	6,37%							10,26%	Belum mencapai standar

4.1.3 IRNA 2C

Tabel 3.3 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2C Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keteranga n
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,11%	87,50%	86,41%	86,93%	86,94%	87,13%							86,67%	Sudah mencapai standar

2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,53%	100%	100%	100%	100%	100%							99,42%	Belum mencapai standar (Jan)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	83,45%	83,57%	76,06%	85,95%	87,59%	91,74%							84,73%	Belum mencapai standar (Mar)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	95,62%	100%	98,46%	100%	100%	100%							99,01%	Belum mencapai standar (Jan, Mar)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,28%	86,56%	84,78%	87,72%	87,04%	87,23%							86,60%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	20%	24,29%	5.6%	0%	0%							8,86%	Belum mencapai standar (Feb-Apr)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan	0%	0%	34,34%	8,62%	0%	0%	14,05%							9,50%	Belum mencapai standar

[illegible]

4.1.4 IRNA 3A

Tabel 3.4 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3A bulan Juni Tahun 2026

[illegible]

1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien									Tdk ada pasien
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien									Tdk ada pasien
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien									Tdk ada pasien
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien									Tdk ada pasien
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien									Tdk ada pasien
Indikator Mutu Prioritas Unit																	

1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien

4.1.5 IRNA 3C

Tabel 3.5 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3C bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterang an
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,74%	84,12%	83,43%	83,10%	83,20%	83,20%							83,47%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,14%	100%	100%							99,86%	Belum mencapai

																standar (Apr)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	96,39%	100%	100%	100%	100%							99,40%	Belum mencapai standar (Feb)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	75,47%	77,36%	76,92%	78,43%	78,43%	78,43%							77,51%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakuka n penguku ran	95,9%	100%	100%	100%	100%							99,18%	Belum mencapai standar (Feb)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadi an	Blm dilakuka n penguku ran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak	0%	Blm dilakuka	20%	0%	0%	0%	0%							4,00%	Belum mencapai

	dilaksanakan visite		n penguku ran													standar (Feb)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakuka n penguku ran	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Belum mencapai standar

4.1.6 IRNA 4A

Tabel 3.6 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 4A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,34%	85,44%	85,44%	85,00%	85,00%	85,32%							85,26%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	93,62%	90,27%	95,76%							96,61%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	59,36%	60,82%	63,42%	51,14%	93,33%							71,35%	Belum mencapai standar (Feb-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,21%	87,72%	85,96%	88,89%	88,89%	87,23%							87,48%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	86,67%	86,19%	79,51%	99,62%	72,67%	96,54%							86,87%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	(Pelayanan Klinis Prioritas)															
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	49,33%	28,8%	48,24%	8,7%	0%	0%							22,51%	Belum mencapai standar (Jan-Apr)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	14,44%	20,83%	15,12%	17,12%	9,58%	0%							12,85%	Belum mencapai standar (Jan-Mei)

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,85%	88,17%	89,49%	85,94%	86,23%	87,53%							87,37%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	86,77%	86,96%	86,67%	85,81%	90,97%	86,50%							87,28%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,06%	100%	89,23%	96,61%							97,48%	Belum mencapai standar (Mar-Jun)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	84,73%	89,47%	83,33%	83,7%	82,68%	90,6%							85,75%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	98,51%	96,09%	98,41%							98,84%	Belum mencapai standar (Apr-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	87,04%	88,33%	91,07%	91,67%	92,59%	94,44%							90,86%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	96,52%	100%	100%							99,30%	Belum mencapai standar (Apr)
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	10,53%	16%	15,96%	10,62%	7,01%							12,02%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	3,08%	0%	4,27%	8,08%							3,09%	Belum mencapai standar

4.1.8 IRNA 6A

Tabel 3.8 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 6A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	82,69%	82,79%	83,03%	82,64%	82,76%	83,06%							82,83%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	95%	100%	100%	89,23%	100%							97,37%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	57,95%	70,91%	60,77%	63,03%	82,68%	69,63%							67,50%	Belum mencapai standar (Jan, Feb, Mar, Apr, Jun)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	94,29%	100%	100%	96,09%	100%							98,40%	Belum mencapai standar (Feb, Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	84,44%	82,61%	84,09%	83,72%	85,37%	90,48%							85,12%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	(Pelayanan Klinis Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	50%	0%	45,65%	21,67%	23,2%							28,10%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	37,5%	0%	0%	0%	0%							7,50%	Belum mencapai standar (Feb)

4.1.9 IRNA 7A

Tabel 3.9 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 7A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,94%	84,17%	83,70%	83,94%	83,24%	82,76%							83,63%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100,00%	97,78%	100%	100%	100%							99,63%	Belum mencapai standar (Mar)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	92%	94,92%	100%	100%	95,36%							97,05%	Belum mencapai standar (Feb, Mar, Jun)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	64,91%	82,94%	94,3%	86,7%	79,49%	59,31%							77,94%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6	100%	84,51%	84,72%	84,72%	84,51%	86,76%	87,14%							85,39%	Belum mencapai standar

[illegible]

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	28,57%	41,48%	26,44%	24,89%	8,68%							28,75%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	18,93%	20,44%	26%	3,56%							12,70%	Belum mencapai standar

4.1.10 IRNA 8A

Tabel 3.10 Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 8A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	84,18%	83,33%	83,92%	83,71%	84,45%	82,41%							83,67%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	79,84%	92,59%	75,83%	76,33%	89,52%	100,00%							85,69%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	53,12%	96,95%	75,38%	92,37%	88,73%	88,7%							82,54%	Belum mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	90,8%	100%	100%							98,47%	Belum mencapai standar (Apr)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	85,25%	88,00%	85,00%	87,93%	87,27%	87,50%							86,83%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	(Pelayanan Klinis Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	24,31%	7,88%	11,27%	10,98%							10,89%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	26,74%	9,66%	12,37%	11,74%							12,10%	Belum mencapai standar

4.1.11 ICU

Tabel 3.11 Capaian Indikator Mutu Unit ICU bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,80%	88,42%	86,58%	87,30%	91,33%	98,04%							89,75%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%							99,83%	Belum mencapai standar (Jan)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	94,44%	100%							99,07%	Belum mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,58%	90%	100%	100%	100%	100%							97,76%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	93,1%	100%	94,87%	94,44%	100%							97,07%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6	100%	87,10%	88,00%	86,89%	90,00%	89,77%	100,00%							90,29%	Belum mencapai standar

	langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,04%	100%	94,87%	100%	100%							97,18%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	0%	Blm dilakukan pengukuran	70.45%	0%	0%	1,82%	0%							0,46%	Belum mencapai standar
2	Kejadian kesalahan saat hand over (serah terima)	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pasien	0 kejadian	0	0	1	0	0	0							0,17	Belum mencapai standar (Mar)
4	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	<3%	0	4	0	1	0%	0%							0,83	Sudah mencapai standar (Feb, Apr)

4.1.12 PICU

Tabel 3.12 Capaian Indikator Mutu Unit PICU bulan Juni Tahun 2026

[illegible]

1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	Tdk ada pasien							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	28,57%	0%	10%	0%	Tdk ada pasien							7,71%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	18,75%	33,33%	0%	0%	Tdk ada pasien							10,42%	Belum mencapai standar (Feb,Mar)

4.1.13 Instalasi Rawat Jalan

Tabel 3.13 Capaian Indikator Mutu Unit IRJA bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	87,21%	88,17%	84,71%	86,67%	100%	100%							91,13%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,63%	95,82%	96,31%	97,68%	97,51%	98,06 %							96,67%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	96,09%	100%	99,9%	100%	100%							99,33%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)

4	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	100%	86,29%	89,59%	95,04%	95,98%	93,8%							93,45%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	88,46%	88,89%	90,20%	88,24%	82,98%	90,74 %							88,25%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan DPJP terhadap jadwal Praktek	100%	76,78%	87,6%	84,62%	85,31%	85,66%	84,28 %							84,04%	Belum mencapai standar
2	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja	0%	2,43%	2,55%	2,43%	2,14%	2,46%	1,83%							2,31%	Belum mencapai standar
3	Target Pasien PRB dan iterasi	100%	100%	100%	98,49% %	100%	100%	99,7%							99,94%	Belum mencapai standar (Mar)
4	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,34%	90,21%	90,21%	89,93%	91,20%	91,80%							90,62%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit	≥ 80%	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	53,38%	49,57%	47,76%	86,09%	87,27%	90,7%							69,13%	Belum mencapai standar
6	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	95,36%	95,45%	100%							98,47%	Belum mencapai standar (Apr-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6	100%	86,30%	86,11%	86,11%	87,67%	88,24%	89,06%							87,25%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	0%	0%	0%	0%	11,92%	17,27%	20,45%							8,27%	Belum mencapai standar
2	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Kejadian perdarahan post partum	0 kejadian	3	3	2	3	0	2							2	Belum mencapai standar
4	Angka kejadian partus macet	< 10%	18,5%	31,3%	33,3%	13,21%	4,7%	10%							18,50%	Belum mencapai standar
5	Kejadian eklamsi	0 kejadian	3	0	0	0	0	0							1	Belum mencapai standar (Jan)

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
6	Kejadian pre eklamsi	0 kejadian	0	1	1	4	0	4							2	Belum mencapai standar
7	Kejadian infeksi nifas	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
8	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	13,91%	12,73%	6,82%							5,58%	Belum mencapai standar (Apr-Jun)
9	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

4.1.16 Neonatologi

Tabel 3.16 Capaian Indikator Mutu Unit Neonatologi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,88%	89,47%	90,88%	91,03%	90,77%	91,82%							90,81%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	93,33%	100%	95%	89,36%	97,67%							95,89%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	98,25%	98,25%	98,25%	98,28%	98,08%	97,73%							98,14%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	1.59%	0%	1,18%	1,04%							0,44%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

4.1.17 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

Tabel 3.17 Capaian Indikator Mutu Unit IKO bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	94,44%	94,11%	94,44%	94,80%	94,80%	94,80%							94,57%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
																standar (Mei-Jun)
4	Penundaan operasi elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (SKP 4)	100%	100%	100%	100%	100%	97.78%	91,01%							98,20%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
2	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	92,86%	95,35%	92,86%	92,68%	90,24%	90,24%							92,37%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan pemasangan handrail dan	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	penguncian roda brankar (SKP 6)															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian re operasi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	0%	9,45%	9,32%	1,49%	3,83%	2,52%	0,56%							4,53%	Belum mencapai standar
3	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

4.1.18 Instalasi Laboratorium

Tabel 3.18 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Laboratorium bulan Juni Tahun 2026

[illegible]

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
1	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	0 kejadian	48	24	27	12	69	53							39	Belum mencapai standar
2	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	100%	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	100%	Tdk ada kejdian							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	100%	94,51%	92,71%	100%	96%	93,94%	96.83%							95,43%	Belum mencapai standar

4.1.19 Instalasi Radiologi

Tabel 3.19 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Radiologi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,62%	83,88%	83,33%	83,04%	83,89%	83,88%							83,61%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (SKP 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	89,66%	88,52%	89,47%	89,29%	90,74%	93,88%							90,26%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	16	5	5	9	5							8	Belum mencapai standar
2	Kejadian keterlambatan hasil radiologi	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	40	30	30	32	31							33	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata	Ket
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,09%	89%	60,64%	70%	87,18%							79,58%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%	100%	99,17%	99,26%	100%	100%							99,74%	Belum mencapai standar
3	Angka kelengkapan pengkajian gizi	100%	100%	100%	99,91%	100%	99,7%	100%							99,94%	Belum mencapai standar
4	Kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap	0 kejadian	2	1	1	2	1	3							2	Belum mencapai standar
5	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0 kejadian	0	0	0	0	1	0							0	Belum mencapai standar
6	Kejadian makanan basi	0 kejadian	1	1	0	0	0	0							0	Belum mencapai standar

4.1.20 Instalasi Farmasi

Tabel 3.20 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Farmasi bulan Mei Tahun 2026

[illegible]

[illegible]

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0 kejadian	0	0	0	0	0	0								Sudah mencapai standar
3	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	0 kejadian	2	4	6	2	1	0								Belum mencapai standar
4	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	0 kejadian	1	2	0	1	0	1								Sudah mencapai standar
5	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	0 kejadian	1	0	0	1	0	0								Sudah mencapai standar
6	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	0 kejadian	1	4	0	0	1	1								Belum mencapai standar

4.1.21 Pengadaaan Farmasi

Tabel 3.21 Capaian Indikator Mutu Unit Pengadaan Farmasi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
----	-----------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----

Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan sediaan farmasi datang	0%	Blm dilakukan pengukuran	20,6%	28%	32,8%	26,76%	40,88%							29,81%	Belum mencapai standar
2	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Angka selisih stok opname	0%	Blm dilakukan pengukuran	0,88%	0,73%	0,99%	0,64%	0,55%							0,76%	Belum mencapai standar
4	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	100%	Blm dilakukan pengukuran	93,75%	97,37%	100%	100%	100%							98,22%	Belum mencapai standar (Feb,Mar)

4.1.22 Komite PPI

Tabel 3.22 Capaian Indikator Mutu Komite PPI bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Komite																
1	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar

1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	0 kejadian	0	0	0	1	0	0							1	Sudah mencapai standar
2	Angka turn over staf	0%	1,38%	0%	0,28%	0,55%	1,38%	0,55%							0,69%	Belum mencapai standar

4.1.24 Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran)

Tabel 3.24 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran) bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pendaftaran pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	25	25	38	32	0							24	Belum mencapai standar
2	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	4	1	1	0	0							1	Belum mencapai standar
3	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	1	5	0	1							1	Belum mencapai standar

4	Klaim tidak layak	0%						0,03%								
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	< Rp1.000.000														
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	< Rp5.000.000														
7	Nilai selisih negatif klaim RJTL	< Rp50.000.000	251.175.040	232.420.655	151.929.783	251.293.106	209.944.684	Rp266.005.258								
8	Nilai selisih negatif klaim RITL	< Rp100.000.000	- 1.216.032.654	-	-	- 1.462.313.938		Rp- 557.824.591								
9	Persentase readmisi pasien rawat inap	0%	3,5%	1,83%	2,34%	3,51%	2,47%	3%								Belum mencapai standar
10	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	66,4%	42,32%	61,43%	69,52%	66,6%	77,3%								Belum mencapai standar

4.1.28 PIPP

Tabel 3.28 Capaian Indikator Mutu Unit PIPP bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
2	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%							99,75%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kejadian komplain pasien/keluarga di google review (Tujuan Strategis)	0 kejadian	5	1	3	11	7	4							5	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kepuasan Pasien Peserta BPJS	100%	99,89%	100%	100%	100%	99,91%	99,9%							99,96%	Belum mencapai standar
2	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

1	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	≥ 90%	90.91%	79.1%	84.62%	88.07%	92,39%	90%							91,20%	Sudah mencapai standar
---	---	-------	--------	-------	--------	--------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--------	------------------------

4.1.30 Kesekretariatan

Tabel 3.30 Capaian Indikator Mutu Unit Kesekretariatan bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen <i>meeting</i> RS (saat akhir rapat)	0%	25%	0%	0%	0%	Tidak ada rapat	28,57%								-

4.1.31 CSSD & Laundry

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Unit CSSD & Laundry bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan penggunaan alat	100%	84,41%	89,29%	87,22%	75,56%	79,03%	75,56%							81,85%	Belum mencapai standar

1	Kejadian CCTV tidak terecord	0 kejadian	0	0	2	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Kejadian komputer dan internet lemot	0 kejadian	60	53	17	17	22	12							30	Belum mencapai standar

4.1.33 Kamar Jenazah

Tabel 3.32 Capaian Indikator Mutu Unit Kamar Jenazah bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%	Sudah mencapai standar

4.1.34 Driver

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	0 kejadian	0	4	1	2	0	0							1	Sudah mencapai standar

2	Kejadian oncall driver	0 kejadian	3	5	2	2	3	2							3	Belum mencapai standar
3	Penggunaan ambulance luar RS	0 kejadian	12	11	10	5	2	2							7	Belum mencapai standar

4.1.35 Security

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	0 kejadian	1	0	1	1	0	0							1	Sudah mencapai standar
2	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	0 kejadian	15	14	13	26	29	22							20	Belum mencapai standar

4.1.36 Gudang Umum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0 kejadian	4	8	1	4	3	2							4	Belum mencapai standar

4.1.37 Kasir

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	0 kejadian	2	5	5	7	1	0								Belum mencapai standar
2	Keterlambatan pelunasan pembayaran	0 kejadian	1	1	0	0	0	0								Sudah mencapai standar
3	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	0 kejadian	2	5	5	7	10	0								Belum mencapai standar

4.1.38 Humas

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	0 kejadian	0	0	0	1	1	2							1	Belum mencapai standar

4.1.39 Primantara

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplain keterlambatan pengantaran obat	0 kejadian	1	1	0	2	2	0							1	Belum mencapai standar

4.1.40 PKRS

[illegible]

4.1.41 PROGNAS KB

[illegible]

3	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0														
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.1.42 PROGNAS TB

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

4.1.43 PROGNAS HIV

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

4.1.44 PROGNAS STUNTING

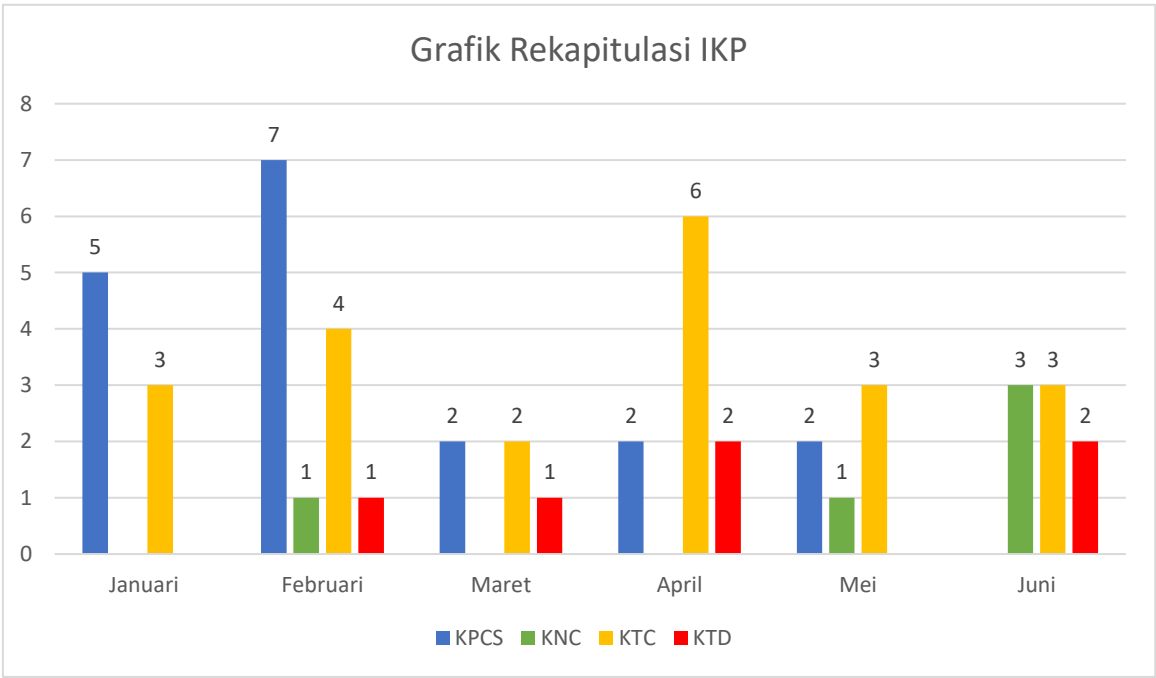
[illegible]

BAB V
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

5.1 Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

Tabel 5.1 Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

	KPCS	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	7	1	4	1		13
MARET	2		2	1		5
APRIL	2		6	2		10
MEI	2	1	3			6
JUNI		3	3	2		8
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	16	6	22	6		50



Gambar 5.1 Grafik Rekapitulasi Insiden Keselamatan Pasien Berdasarkan Jenis Insiden

5.2 Laporan IKP Triwulan II Tahun 2026

a. Bulan April

No.	TGL KEJADIAN	UNIT	GRADING	JENIS IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1	06 April	Maternitas	Biru	KTC	Bidan salah menginput data di kematian maternal yang seharusnya di kematian abortus di web MPDN, sehingga data yang diisi sesuai dengan KTP Ibu.	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaporkan ke Kemenkes RI sehingga data kematian maternal sudah dihapus. 2. Dilakukan input kematian abortus. 3. Penyampaian kesalahan input di aplikasi kepada pasien dan suami pasien oleh MOD.
2	11 April	Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan penulisan etiket obat antara antibiotik dan obat anti nyeri sehingga pasien tidak menghabiskan antibiotik yang seharusnya dihabiskan	1. Melakukan pengecekan ulang etiket setelah di print. 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE

3	12 April	IRNA 2C	Hijau	KTC	Kesalahan pemberian obat injeksi. Perawat memberikan obat kepada pasien anak dengan cara dibolus, seharusnya obat pekat diberikan secara didrip, sehingga anak menangis. Lalu keluarga komplain karena infus tiba-tiba menetes cepat.	1. (a) Pendokumentasian perintah DPJP dalam pemberian obat terutama untuk jenis injeksi kepada pasien anak-anak. (b) Jika cara pemberian obat belum jelas dan perawat ragu-ragu atau bingung, boleh bertanya ke DPJP. (c) Refreshing 5B pemberian obat. (d) Memberikan informasi yang detail dan jelas termasuk pemberian obat saat operan shift. 2. Perawat senior harus mendampingi perawat baru setiap melakukan tindakan ke pasien. 3. (a) KIE kepada keluarga pasien terutama pasien anak, jika infus menetes cepat, bisa memberitahu perawat. (b) Menggunakan prosedur yang benar saat membenahi tetesan infus. 4. Masukan dari dr. Heru, jika terjadi komplain, boleh meminta DPJP untuk menjelaskan ke keluarga pasien, agar lebih membuat tenang. 5. Koordinasi dengan komite keperawatan
---	----------	---------	-------	-----	--	--

4	14 April	IGD	Hijau	KPC	Kesalahan penulisan form SBAR karena perawat copy paste advice DPJP di WA tanpa melakukan pengecekan ulang identitas pasien sehingga form SBAR yang tertulis di e-RM adalah milik pasien lain.	1. Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM
5	16 April	Farmasi	Hijau	KTC	Kejadian kesalahan pemberian antibiotik karena staf farmasi kurang teliti menyiapkan obat. Perawat IRNA hanya double check di etiket tapi tidak di obatnya sehingga tidak menyadari obat yang diberikan farmasi berbeda dengan obat yang diadvicekan DPJP	1. Melakukan pengecekan ulang/verifikasi obat sesuai SPO Verifikasi Pemberian Obat Rawat Inap dan pelaksanaan 5 benar telaah obat (Benar Pasien, Benar Obat, Benar Dosis, Benar Rute, Benar Waktu Pemberian)
6	21 April		Hijau	KTD	Kejadian penurunan kesadaran dan gangguan napas pasca operasi remove implant diduga dipicu krisis hipertiroid yang sebelumnya tidak teridentifikasi saat pengkajian praoperasi karena pasien memiliki riwayat hipertiroid namun tidak rutin berobat, sehingga pasien memerlukan perawatan intensif di ICU.	1. Melakukan penguatan pengkajian praoperasi sesuai SPO asesmen pra anestesi dan pra operasi melalui verifikasi ulang riwayat penyakit pasien, riwayat pengobatan, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan, disertai peningkatan komunikasi dan koordinasi antar DPJP, dokter anestesi, perawat, dan pasien/keluarga guna meminimalkan risiko komplikasi perioperatif.

7	22 April	Maternitas	Hijau	KTD	Bidan memberikan premed ondansentron padahal DPJP tidak memberi advice tersebut. Kemudian muncul bentol-bentol di tangan pasien akibat reaksi alergi ondansentron sehingga pelaksanaan kuret ditunda	1. Pengkajian alergi harus terkaji mulai awal, jika di awal belum terkaji, harus dikaji pada tahap selanjutnya. 2. Memberikan pertanyaan terbuka jika bertanya ke bidan lain mengenai premed yang diberikan. Bidan juga harus meningkatkan fokus dan tidak memberikan tanggapan dengan mengangguk saja. 3. Melihat kembali advice DPJP di WA sebelum memberikan asuhan pada pasien.
8	23 April	Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan penyiapan obat karena petugas tidak teliti konversi dosis sesuai obat yang tersedia sehingga jumlah obat kurang	1. Melakukan pengkajian resep dan konversi dosis sesuai resep. 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
9	24 April	Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan penyiapan obat diawali dari DPJP tidak teliti dalam menginput resep, kemudian sudah direvisi namun petugas tidak teliti menyiapkan obat yang seharusnya diberikan sebanyak 60 tablet, hanya diberikan sebanyak 30 tablet. Lalu apoteker melakukan identifikasi	1. Koordinasi dengan komite medik 2. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). 3. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label

					pasien dan melakukan double check etiket dan obat dengan resep namun tidak teliti melihat kesesuaian resep dan jumlah obat.	ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
10	29 April	IGD	Hijau	KPC	Kesalahan penulisan SBAR karena perawat langsung mengcopy paste advice DPJP tanpa melihat identitas pasien.	1. Melakukan <i>crosscheck</i> sebanyak 3x saat menuliskan SBAR di E-RM 2. Harus melihat identitas sebelum menulis SBAR di E-RM

b. Bulan Mei

No.	TGL KEJADIAN	UNIT	GRADING	JENIS IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1	6 Mei	IRNA 5C	Biru	KPCS	Sonde pasien tidak ber-etiket karena adanya perubahan diit mendadak sehingga petugas gizi memberikan sediaan sonde yang dibawa dan belum diberikan label.	1. Larangan menaruh sonde tanpa etiket di nurse station meskipun untuk sementara
2	7 Mei	IPSRs	Hijau	KPCS	Lantai basah di depan UPS CT Scan bersumber dari tetesan sisa genangan air di ember alat AC yang ada di atas troli alat AC setelah melakukan pencucian di ruang operasi.	1. Menghubungi CS untuk segera mengepel genangan air 2. Melakukan double check setiap selesai melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana

3	9 Mei	Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan Input E-Resep oleh DPJP dan Kesalahan Penulisan Etiket Obat racikan puyer tertera rute topikal dan cara penggunaan dioleskan.	1. Koordinasi dengan komite medis 2. Menegur staf yang bersangkutan dan sosialisasi kembali SPO pengkajian resep. 3. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check).
4	16 Mei	IRNA 5C	Hijau	KTC	Terjadi kesalahan interpretasi instruksi dokter terkait pemeriksaan laboratorium ulang, sehingga terdapat pemeriksaan yang dilakukan kembali di ruang rawat inap padahal instruksi tersebut telah ditujukan untuk pelaksanaan di IGD.	1. Penggantian biaya laboratorium oleh perawat
5	24 Mei	Instalasi Gizi	Hijau	KNC	Terjadi kesalahan pemberian diet pada pasien, di mana instruksi diet cair Diabetasol oleh DPJP pada pagi hari tidak sesuai dengan pesanan diet yang dibuat oleh ahli gizi	1. Ahli gizi bisa melihat operan pasien atau cppt untuk mengetahui diet yang di advice kan dpjp 2. Ahli gizi bisa lebih teliti lagi dalam meberikan jenis Diet

					menjelang siang, sehingga pasien hampir menerima diet cair sonde yang tidak sesuai saat makan siang.	kepada pasien
6	29 Mei	Instalasi Gizi	Hijau	KTC	Ditemukan benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu)	1. Pemorsian snack dilakukan minimal 1 jam sebelum di bagikan tidak boleh H-1 sebelum di bagikan 2. Setelah sudah diporsi dan di beri plastic wrap disimpan/diletakkan di tempat yang aman agar tidak ada benda asing yang masuk 3. Seperti makan pasien, snack juga harus di QC oleh ahli gizi sebelum di bagikan oleh penyaji

c. Bulan Juni

No.	TGL KEJADIAN	UNIT	GRADING	JENIS IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1	01 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KTD	Kesalahan pemberian minuman (teh manis) untuk pasien dengan RPD DM sehingga gula darah pasien naik.	1. Meningkatkan ketelitian saat membagikan snack dengan tetap melihat pemesanan diet 2. Melakukan crosscheck kepada perawat dan pasien/keluarga pasien mengenai riwayat penyakit sebelum membagikan snack/makanan pasien

2	08 Juni	Instalasi Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan Pemberian Obat LASA (di etiket tertulis Codikaf 10 mg tetapi yang diberikan Codikaf 15 mg)	3. Menghubungi pasien untuk crosscheck obat yang diterima, mengarahkan pasien untuk memberhentikan konsumsi Codikaf 15 mg dan mengirimkan Codikaf 10 mg. 4. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
3	08 Juni	Instalasi Farmasi, Instalasi Rekam Medis	Biru	KNC	Pasien double Nomor RM dikarenakan 2x daftar dengan penjamin yang berbeda dan salah satunya menggunakan APM.	1. Apoteker melaporkan kepada Kains untuk melakukan telusur apakah terjadi kesalahan pemberian obat
4	02 Juni	IRNA 2C	Hijau	KTC	Kesalahan dosis pemberian obat, obat yang telah diberikan kepada pasien anak karen perawat tidak double check dan ternyata belum dioplos dan obat sudah dispuir full dosis yang seharusnya pasien hanya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dosis dari sediaan.	1. Meningkatkan pelaksanaan SPO 5 benar dalam pemberian obat
5	10 Juni	IGD	Hijau	KTD	Kesalahan penulisan SBAR dengan menambahkan advice dokter lain yang tidak seharusnya sehingga menyebabkan melena	Meningkatkan ketelitian dan melakukan double check sebelum mengisi form SBAR pasien

6	16 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KNC	Nyaris terjadi kesalahan pemberian diet untuk pasien dengan RPD DM tapi sejak awal tidak diberikan diet DM	1. Meningkatkan ketelitian dengan melihat riwayat penyakit pasien ketika memberikan diet pasien 2. Double check riwayat penyakit pasien sebelum membagikan diet ke pasien secara langsung
7	20 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KTC	Kesalahan pemberian diet karena ahli gizi tidak melihat hasil lab dengan GDS tinggi, seharusnya diberikan diet DM namun ahli gizi memberikan diet TKTP RG.	1. Mengganti diet menjadi diet DM 2. Mengedukasi keluarga tentang diet DM karen GDS tinggi 3. Meningkatkan ketelitian ahli gizi untuk melihat hasil lab pasien sebelum meresepkan diet
8	29 Juni	IGD	Hijau	KNC	Perawat shift pagi salah memberikan konfirmasi pemberian obat kepada perawat shift sore	Melakukan telusur dan mengirimkan foto antara venax dan lovenox agar dapat dikonfirmasi perawat shift pagi

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Komite Mutu rumah sakit di Rumah Sakit Prima Husada Malang Triwulan II Tahun 2026. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dikerjakan saat ini, tentunya upaya yang berkesinambungan dan tidak mengenal lelah terus dilakukan sehingga tercapai hasil tertinggi bagi semua komponen pemberi dan pengguna layanan rumah sakit.

Malang, 20 Juli 2026

Direktur RS Prima Husada Malang

Ketua Komite PMKP



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'dr. Diah Puspita Rifasanti'.

dr. Resti Lestantini, M.Kes

dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M